Boletín Epidemiológico N° 24 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

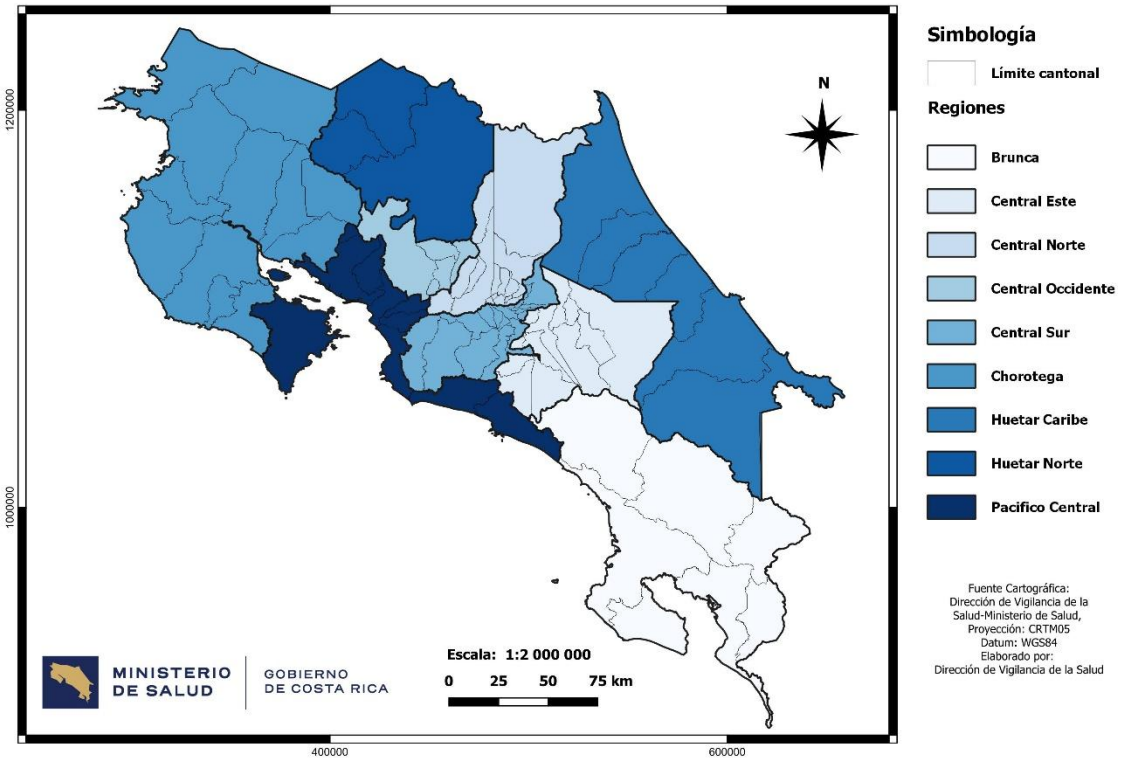
Ministerio de Salud

4 de julio de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 25 .. 9
Malaria 11
Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19 18
Sarampión 34
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 44
Meningitis 46
Infecciones de transmisión sexual 50
Miasis por gusano barrenador en humanos 62

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Adriana Alfaro Nájera
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de Salud

Adrián Montero Bonilla
Unidad de Seguimiento de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Dengue

A la semana epidemiológica 25 del año 2025 se notifican **3186 casos** de dengue, de estos 36 acumulados notificados con signos de alarma.

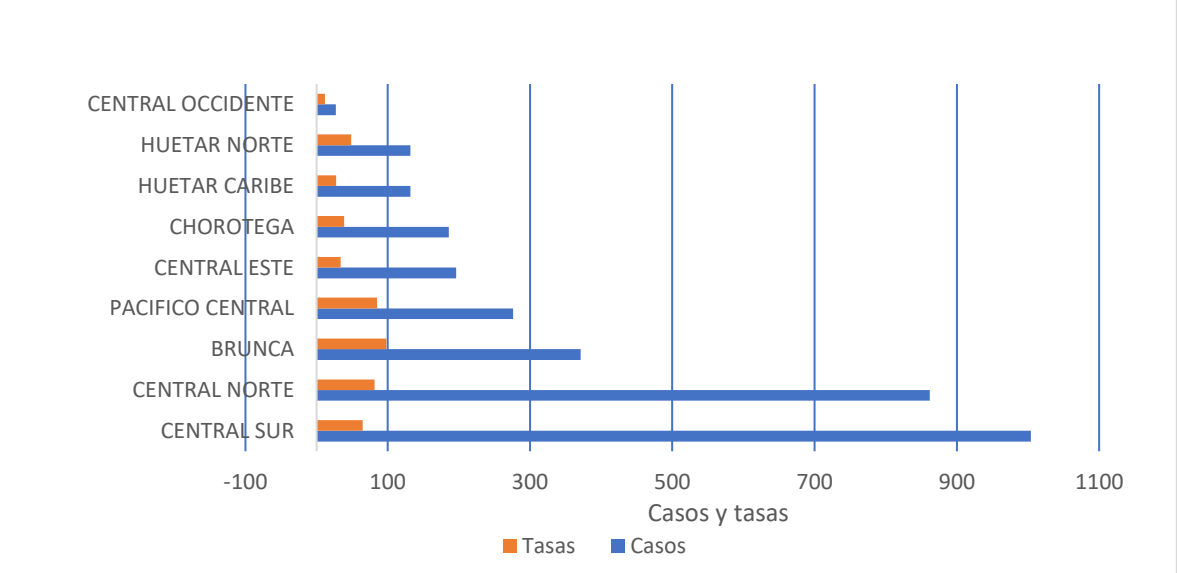
En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 1004 casos y la tasa más alta en la Brunca 98,0/100.000 habitantes.

Tabla 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 25, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
CENTRAL SUR	1004	64,7
CENTRAL NORTE	862	81,5
BRUNCA	371	98,0
PACIFICO CENTRAL	276	85,0
CHOROTEGA	186	38,9
CENTRAL ESTE	196	33,9
HUETAR CARIBE	132	27,3
HUETAR NORTE	132	48,5
CENTRAL OCCIDENTE	27	11,7
Total	3186	59,5

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 1.
Costa Rica: casos de dengue y tasa por región a la semana epidemiológica 25, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

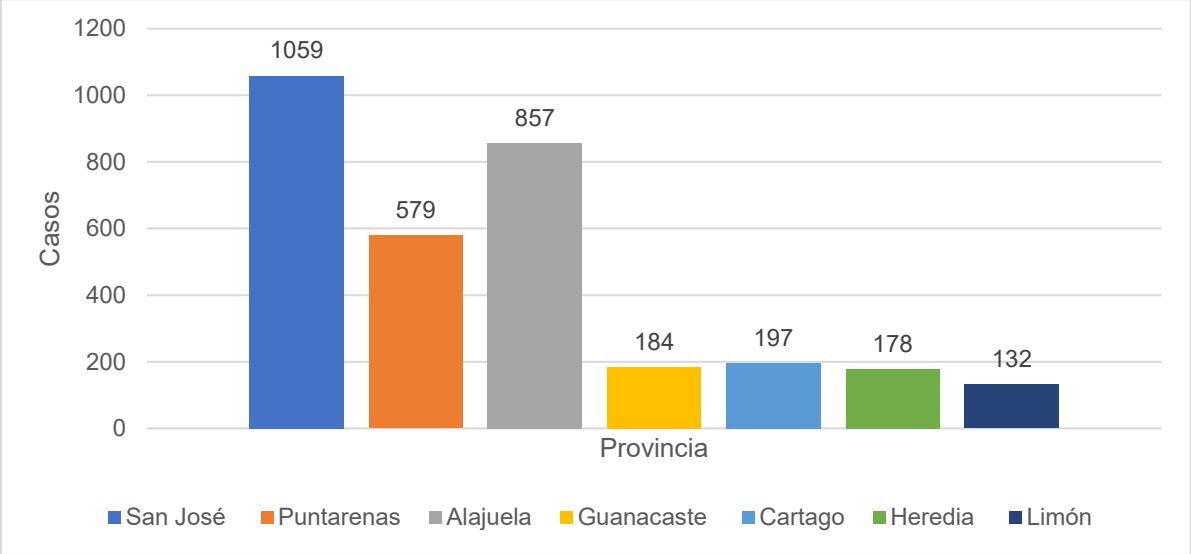
En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Tabla 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	1059	61,7	525	60,8	534	62,6
Puntarenas	579	109,8	248	95,6	331	123,5
Alajuela	857	78,4	408	75,5	449	81,3
Guanacaste	184	43,8	82	39,6	102	47,9
Cartago	197	35,4	90	32,4	107	38,4
Heredia	178	31,9	86	30,9	92	32,8
Limón	132	27,3	61	25,9	71	28,6
Total	**3186**	**59,5**	**1500**	**56,3**	**1686**	**62,6**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

Figura 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia a la semana epidemiológica 25, 2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

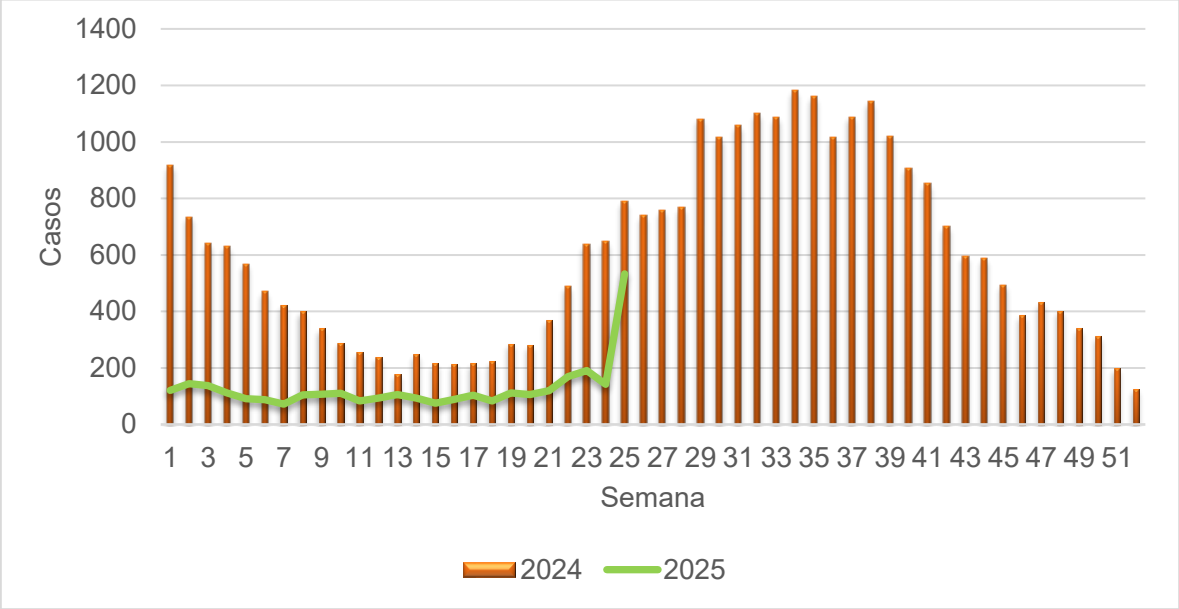
Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 25 son: Alajuela 627 casos, San José 624 casos, Puntarenas 119 casos, Osa 112 casos y Alajuelita 109 casos.

Tabla 3.
Costa Rica: cantones prioritarios en casos de dengue a la semana epidemiológica 25, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
201: Alajuela	627	188,5
101: San José	624	174,3
601: Puntarenas	119	79,7
605: Osa	112	353,5
110: Alajuelita	109	108,1
410: Sarapiquí	102	107,8
210: San Carlos	98	45,7
610: Corredores	90	163,6
602: Esparza	86	211,0
607: Golfito	72	150,4
103: Desamparados	63	24,7
119: Perez Zeledón	56	39,1
303: La Unión	52	44,3
109: Santa Ana	51	79,9
308: El Guarco	45	94,1
702: Pococí	41	25,6
502: Nicoya	37	62,6
305: Turrialba	36	49,2
301: Cartago	34	20,1
603: Buenos Aires	34	59,9

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Figura 3.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 25, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

A la semana epidemiológica 25 del 2024 se reportó un total de 10699 casos de dengue, para este 2025 se reportan 3186 para un descenso del 73%.

Tabla 4.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 25, 2024-2025.

Semana	2024	2025
1	917	121
2	735	144
3	641	138
4	631	112
5	568	91
6	472	88
7	421	72
8	401	105
9	340	107
10	289	110
11	256	83
12	238	93
13	178	106
14	247	93

15	216	75
16	214	89
17	216	104
18	223	83
19	285	112
20	280	106
21	368	119
22	489	169
23	636	191
24	648	142
25	790	533
Total	**10699**	**3186**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Acciones de control vectorial realizadas en el país a la semana epidemiológica 25

Rodrigo Marín Rodríguez
Programa de Control de Vectores
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud.

Rose Mary Hidalgo Ríos
Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM)

En la siguiente tabla se desglosan las acciones de control vectorial que se han realizado en la Semana Epidemiológica 25 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Acciones de control vectorial en la Semana Epidemiológica 25

Total	
Viviendas visitadas	**11.788**
Viviendas positivas	**889**
Depósitos tratados	**59.977**
Depósitos eliminados	**17.501**
Depósitos positivos	**1.811**
Viviendas fumigadas	**14.151**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Así mismo se detalla lo que llevamos de la Semana Epidemiológica 1 a la 25.

Total	
Viviendas visitadas	**309.272**
Viviendas positivas	**12.849**
Depósitos tratados	**1.151.012**
Depósitos eliminados	**794.896**
Depósitos positivos	**22.350**
Viviendas fumigadas	**291.596**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Malaria

Isaac Vargas Roldán
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Sarah Arce Bonilla
Dirección de Vigilancia de la Salud

I. Antecedentes

Costa Rica ha logrado mantener bajos niveles de transmisión de malaria gracias a los esfuerzos continuos y control. Los casos han disminuido notablemente en comparación con el pasado.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud (MINSA) lideran los esfuerzos de vigilancia, diagnóstico y tratamiento de la malaria, junto con el apoyo del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). Se utilizan herramientas para el diagnóstico rápido y monitoreo constante de los casos.

Costa Rica forma parte de la **Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM)** es un esfuerzo conjunto de varios países y organizaciones internacionales con el objetivo de eliminar la malaria en esta región. Esta iniciativa busca coordinar acciones, compartir recursos y conocimientos, y establecer estrategias comunes para combatir y erradicar esta enfermedad.

El objetivo principal para este año es mantener la reducción sostenida de casos de malaria y avanzar hacia la meta de eliminación. Costa Rica se perfila como el próximo país de la región en obtener la certificación de cero casos autóctonos de malaria.

Como parte de las acciones se está priorizando el **fortalecimiento de la red de colaboradores voluntarios** en comunidades con barreras de acceso a los servicios de salud y esfuerzos para acerca el diagnóstico y tratamiento a personas en condición de movilidad humana que llevan su paso por el país.

II. Vigilancia epidemiológica

El histórico de transmisión local de malaria presenta los casos registrados en los años 2023, 2024 y 2025, organizados por semana epidemiológica. Se observa una tendencia general a la disminución de casos en el periodo analizado.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 25, se observa una disminución progresiva en el número de casos de transmisión local de malaria a lo largo de los últimos tres años. En el año 2023, se registraron 345 casos, mientras que en 2024 la cifra se redujo a 154 casos, lo que representa una disminución del 56%. En lo que va del año 2025, se han reportado 6 casos, lo que equivale a una reducción del 98% en comparación con el mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, en lo que va del año 2025 se ha 1 caso introducido en Santa Rosa de Pocosol y se han detectado 14 casos importados de malaria, siento el 79% *P. vivax* (N=11) y 21% *P.falciparum* (N=3) cuya transmisión ocurrió fuera del país. Estos casos fueron identificados en las localidades de San Pablo (Nandayure), San Ramón (San Ramón), Corredores, Pavas (San José), Cutris (San Carlos) y Los Chiles. Las personas afectadas se desempeñan principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas y coligalleros, y además personas que se encuentran en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, ruta migratoria desde América del Sur y de retorno desde México y Gabón, África.

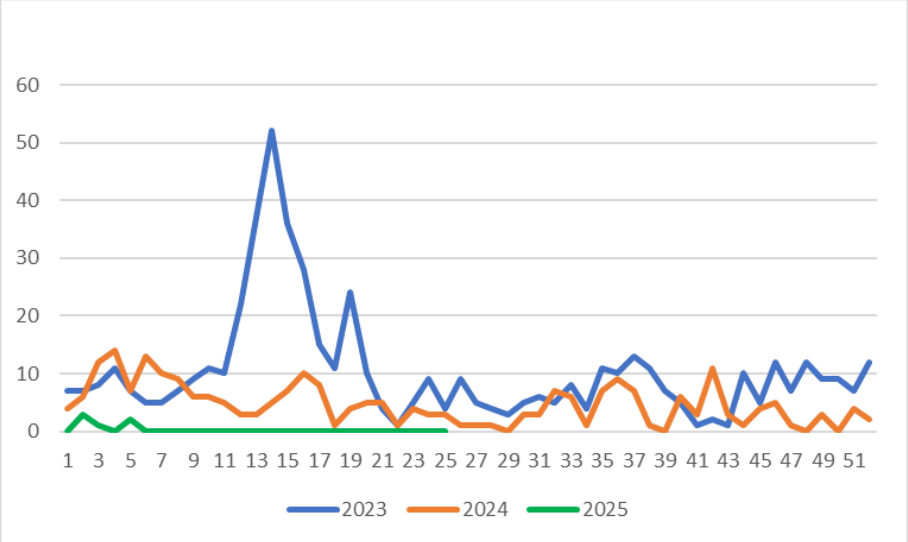
Tabla 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE25.

Histórico Transmisión local			
Semana Epidemiológica	2023	2024	2025
1	7	4	0
2	7	6	3
3	8	12	1
4	11	14	0
5	7	7	2
6	5	13	0
7	5	10	0
8	7	9	0
9	9	6	0

10	11	6	0
11	10	5	0
12	22	3	0
13	37	3	0
14	52	5	0
15	36	5	0
16	28	7	0
17	15	8	0
18	11	1	0
19	24	4	0
20	10	5	0
21	4	5	0
22	1	1	0
23	5	4	0
24	9	3	0
25	4	3	0
Total	**345**	**154**	**6**

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Gráfico 1.
Costa Rica Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 25.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Producción de pruebas de diagnóstico

Se ha llevado a cabo un exhaustivo monitoreo a nivel nacional de la malaria, por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud realizando pruebas de diagnóstico mediante búsquedas pasivas y activas de casos.

A semana epidemiológica 25, se registraron 64.102 pruebas de diagnóstico, las cuales responden a las búsquedas realizadas por las instituciones, desglosadas de la siguiente manera, (refiérase a la figura 1):

- **Pruebas de diagnóstico rápido realizadas por el Ministerio de Salud**: 29405, referirse a la tabla 2.
  - **Colaboradores Voluntarios**: 646
  - **Inspectores de Salud**: 28.759
- **Pruebas de diagnóstico realizadas por CCSS**: 34.697, referirse al gráfico 3.
  - **Gotas gruesas**: 6.219
  - **Pruebas de diagnóstico rápido**: 28.121
  - **PCR**: 357

Estas cifras reflejan un esfuerzo coordinado y continuo para identificar y controlar la propagación de la malaria en el país. La combinación del método tradicional como lo es la gota gruesa y las pruebas rápidas permite una detección más amplia y oportuna de casos, contribuyendo significativamente a la vigilancia epidemiológica y al manejo efectivo de esta enfermedad.

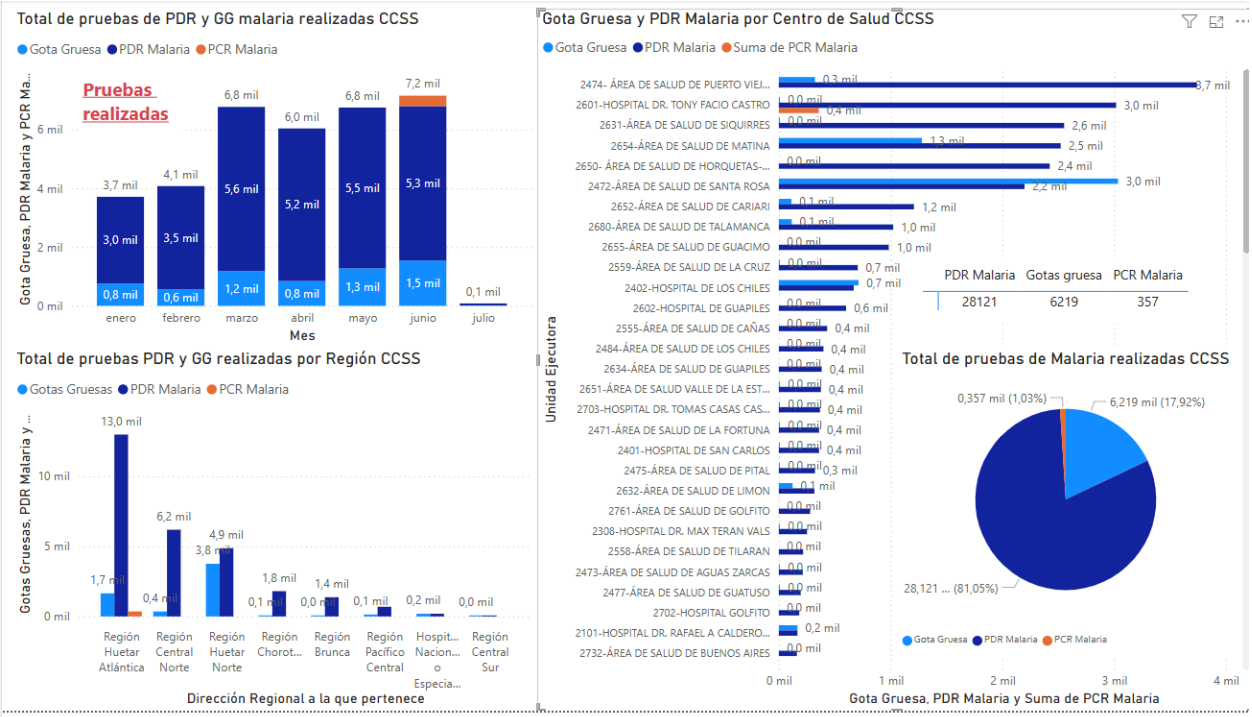
Nota: El registro puede incluir datos duplicados, ya que se toman en cuenta las Gotas Gruesas (GG) para cuantificar la parasitemia antes de iniciar el tratamiento, ante una Prueba de Diagnóstico Rápido (PDR) positiva.

Tabla 2.
Costa Rica: Vigilancia generada por inspectores de salud y voluntarios

Región	Pruebas realizadas por Inspectores de Salud	Pruebas realizadas por voluntarios
Brunca	11369	51
Central Norte	147	28
Chorotega	3270	72
Huetar Caribe	5960	202
Huetar Norte	7331	262
Pacífico Central	1118	31
Total	27187	626

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Ric

Gráfico 3.
Costa Rica Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS



Fuente: CCSS.

Tabla 2.
Costa Rica: Producción de gotas gruesas y PDRs por parte de CCSS por región

Región	Suma de Total de PDR realizadas	Suma de Total de Gotas gruesas analizadas
Región Huetar Atlántica	12981	1650
Región Central Norte	6188	352
Región Huetar Norte	4871	3757
Región Chorotega	1802	73
Región Brunca	1371	31
Región Pacífico Central	689	134
Hospitales Nacionales o Especializados	193	192

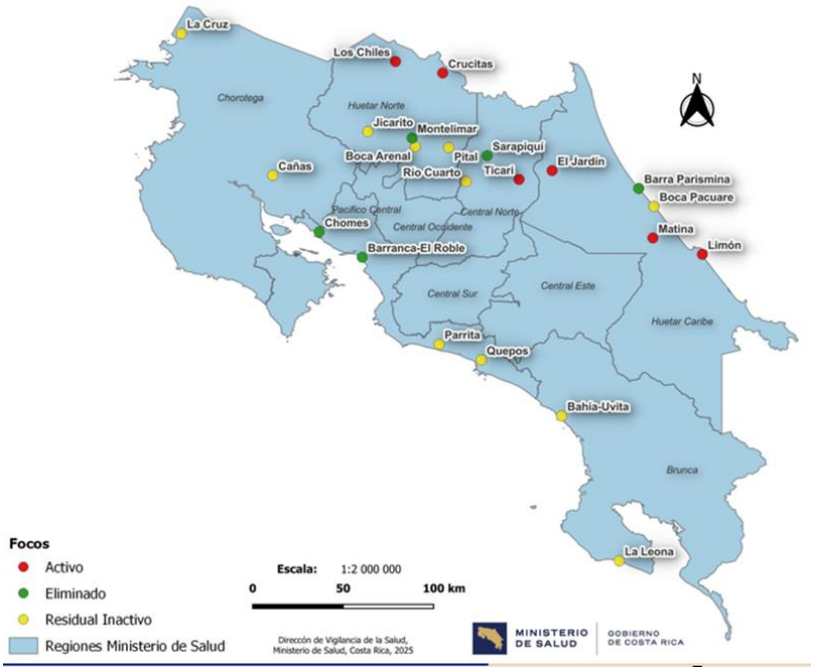
Región Central Sur	26	30
Total general	**28121**	**6219**

Fuente: CCSS.

III. Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

IV. Clasificación del estado histórico y actual de los focos maláricos.

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Tabla 3.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Enero 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Influenza y otras virosis respiratorias, IRAG, IRAS, ETI y Covid-19

Roberto Arroba Tijerino
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Mayra Quesada Sanabria
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

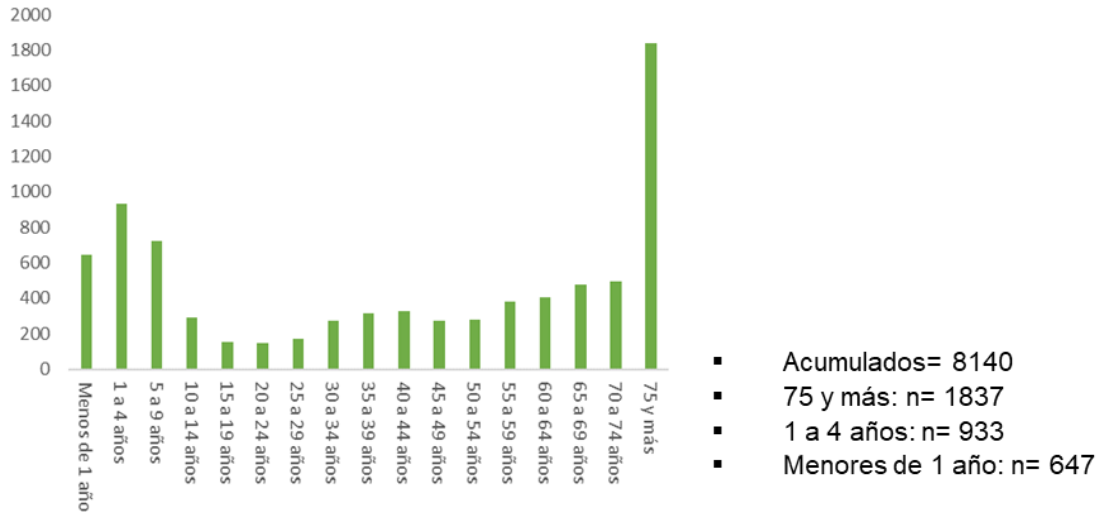
Rafael Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos para la semana epidemiológica 25 de las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) y los datos de la semana epidemiológica 25 de las Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS) y la Enfermedad Tipo Influenza (ETI), que según establece el Decreto de Vigilancia de la Salud No. 40556-S del 07 julio del 2017, son eventos de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de las IRAG, por medio de la boleta VE-01, se cuenta con los siguientes datos:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 25 son un total de 8140.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en los niños entre 1 y 4 años y en los mayores de 75 años.

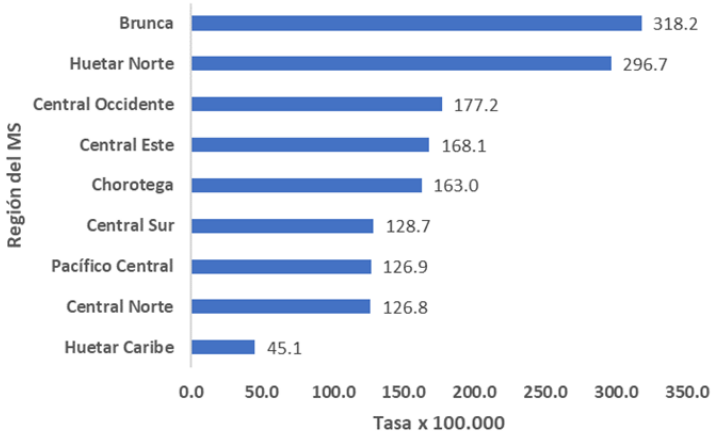
Gráfico 1.
Distribución de casos de IRAG por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según el gráfico 1, se puede apreciar como en los extremos de la vida (niños entre 1 y 4 años y mayores de 75 años es donde más casos se han presentado).
En el gráfico 2, se observa la tasa de incidencia de IRAG según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 25, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Brunca y la Huetar Norte; las regiones con menor incidencia corresponden a la Chorotega, Central Este, Central Occidente, Central Sur, Central Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.

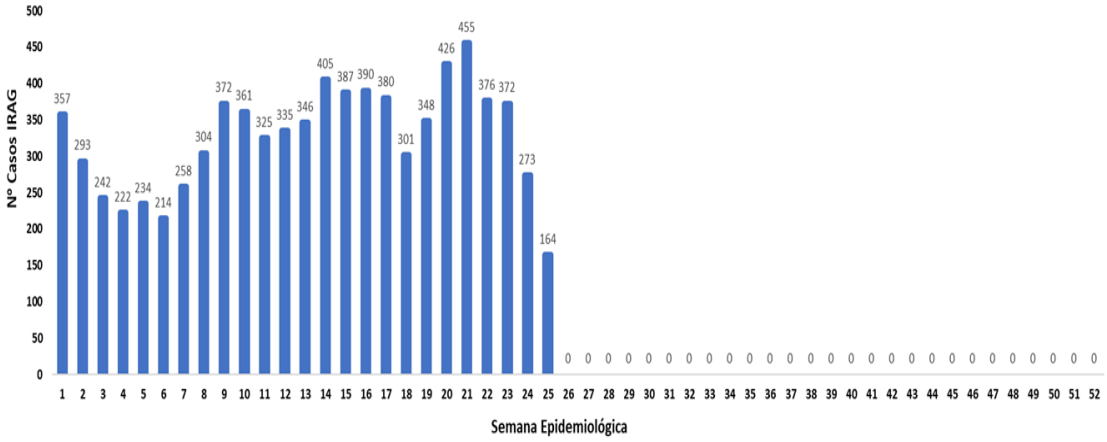
Gráfico 2.
Tasa de IRAG según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 25 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-01 de IRAG, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 3; se puede observar el comportamiento de los casos a la semana epidemiológica 25 del año 2025.

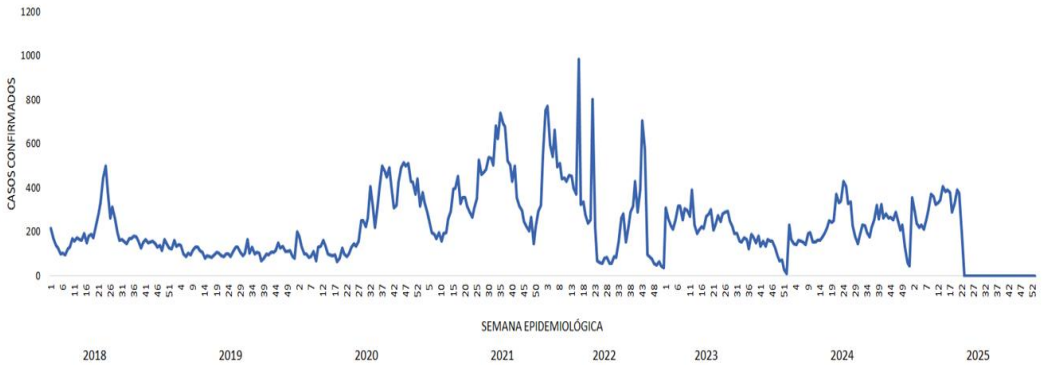
Gráfico 3.
Distribución de casos reportados por boleta VE-01 de IRAG a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAG, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 4.

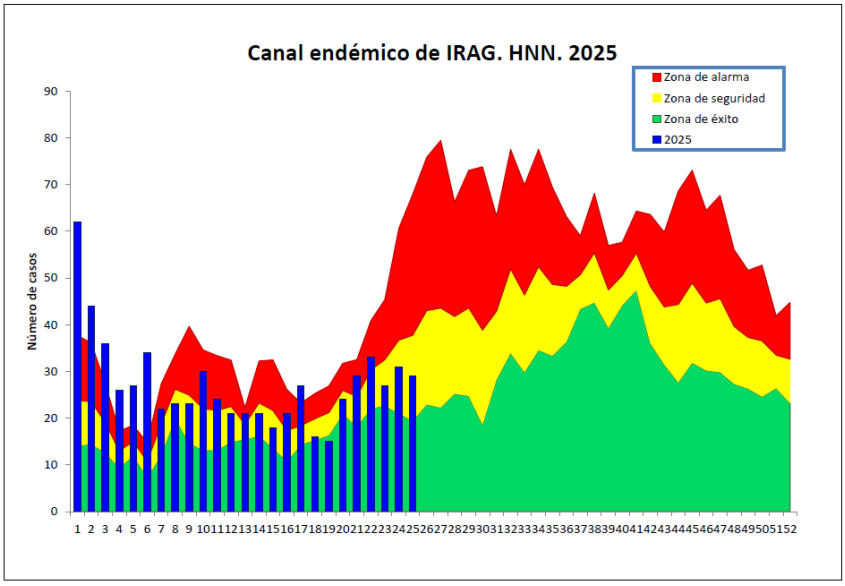
Gráfico 4.
Distribución histórica de casos de IRAG por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

El HNN, para la SE-25 tiene un canal endémico de IRAG que actualmente se encuentra por en zona de seguridad, debido a la cantidad de casos que están presentando en este momento, tal como se puede apreciar en el gráfico 5.

Gráfico 5.
Costa Rica: Canal endémico IRAG, HNN, 2025

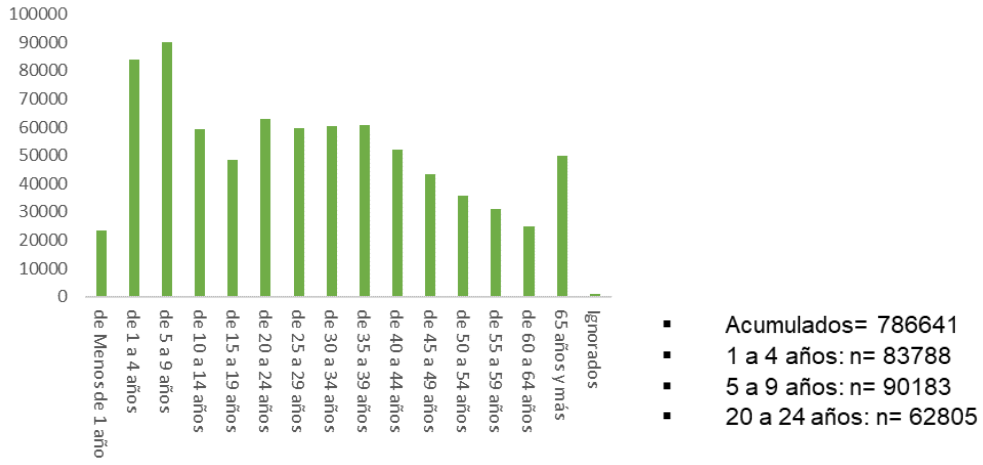


Fuente: EDUS-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de IRAS, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 6:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 25 son 786641.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en menores entre 1 y 4 años y menores entre 5 y 9 años.

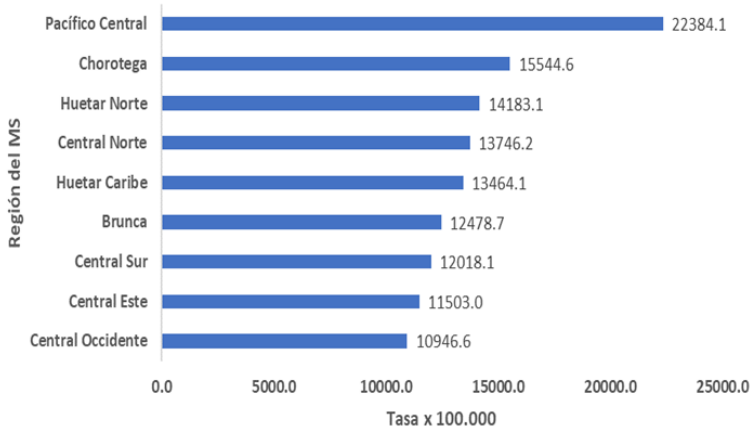
Gráfico 6.
Distribución de casos de IRAS por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 7, se observa la tasa de incidencia de IRAS según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 25, presentando mayor cantidad de casos por cada 100.000 habitantes la Región Pacífico Central, Chorotega y Huetar Norte. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Central Norte, Huetar Caribe, Brunca, Central Occidente, Central Sur y Central Este.

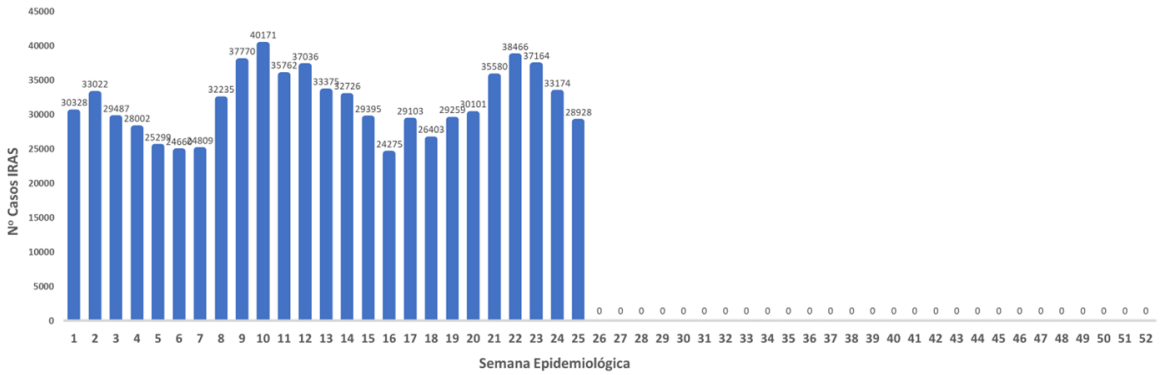
Gráfico 7.
Tasa de IRAS según región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 25 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de IRAS, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 8; se puede observar cómo los casos se han comportado a lo largo de estas 25 semanas epidemiológicas del año 2025.

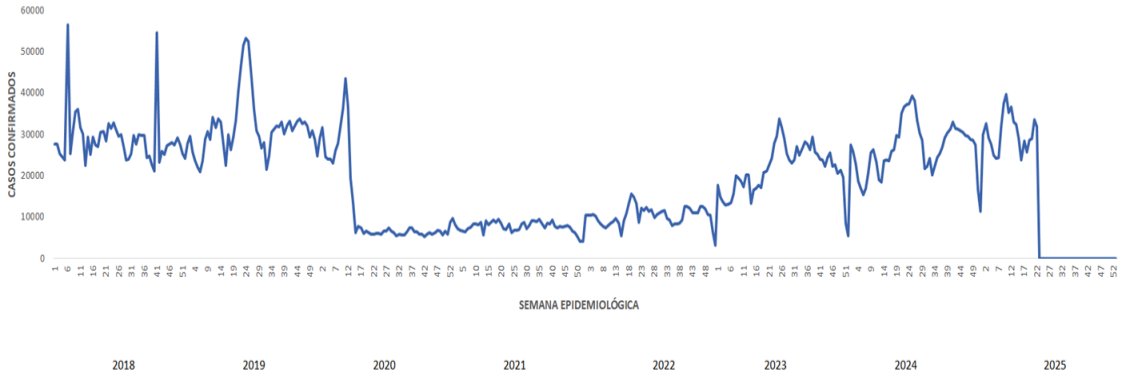
Gráfico 8.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de IRAS a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de IRAS, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 9.

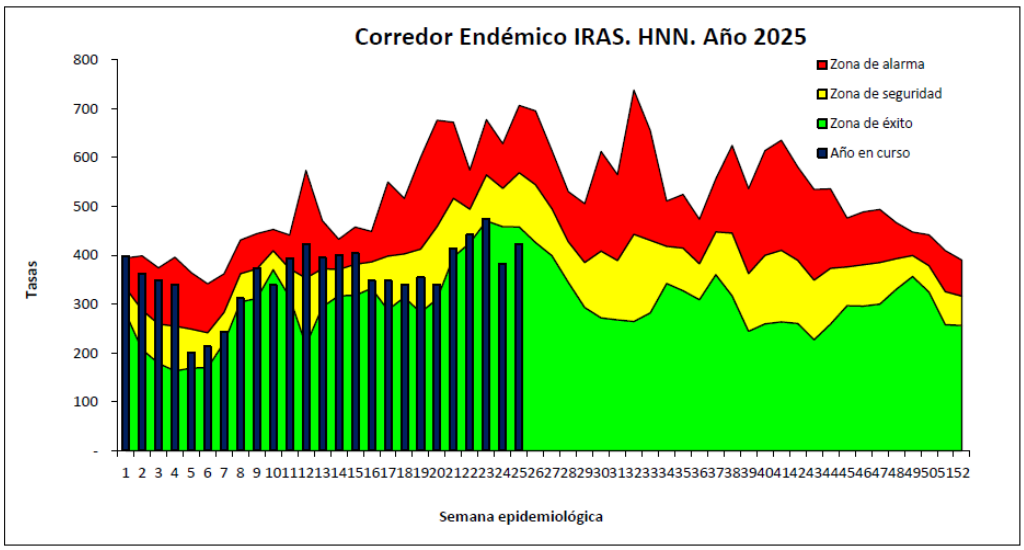
Gráfico 9.
Distribución histórica de casos de IRAS por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 10 se presenta el canal endémico de las IRAS en el Hospital Nacional de Niños, que muestra que a la semana 25 se encuentran en la zona de éxito actualmente.

Gráfico 10.
Costa Rica: Canal endémico IRAS. HNN. 2025.

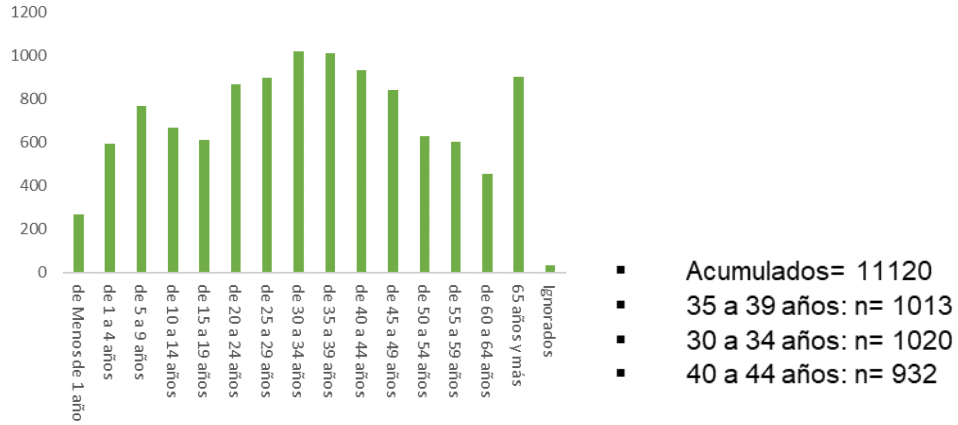


Fuente: Sistemas de Cubos Urgencias-UVEPCI HNN, 2025.

En cuanto a la notificación de ETI, por medio de la boleta VE02, se tiene la siguiente información, tal como se muestra en el gráfico 11:

- Los casos acumulados a la semana epidemiológica (SE) 25 son n= 11120.
- Los casos distribuidos por grupos por edad quinquenal tienen la mayor distribución en personas entre 30 y 34 años y las personas entre 35 y 39 años.

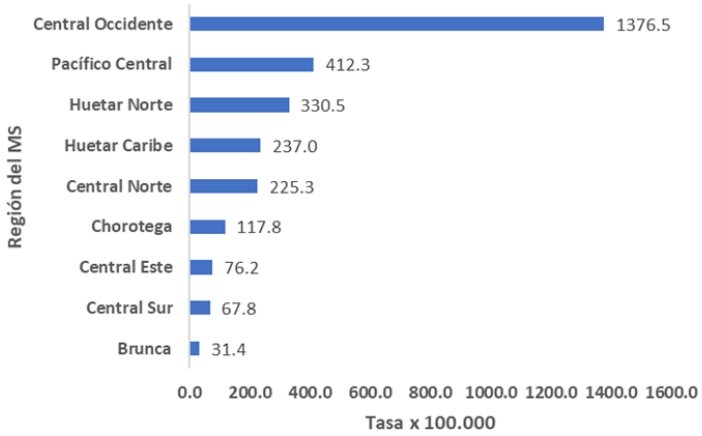
Gráfico 11.
Distribución de casos de ETI por grupos por edad quinquenal, notificados a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En el gráfico 12, se observa la tasa de incidencia por ETI, según las regiones del Ministerio de Salud a la semana 25, presentando mayor cantidad de casos en la región la Central Occidente. Las regiones con menor incidencia corresponden a la región Brunca, Chorotega, Central Este, Central Sur, Huetar Norte, Pacífico Central, Central Norte y Huetar Caribe.

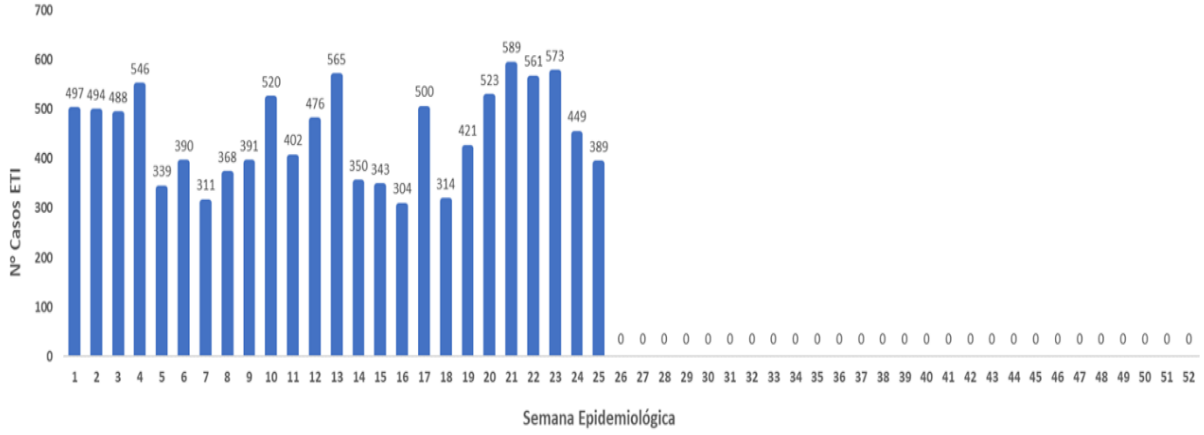
Gráfico 12.
Tasa de ETI por región del Ministerio de Salud, acumulada a la semana epidemiológica 25 del 2025, en Costa Rica.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Por semana epidemiológica, los casos reportados por boleta VE-02 de ETI, en Costa Rica son los que se presentan en el gráfico 13; se puede observar cómo se han distribuido los casos en el año 2025.

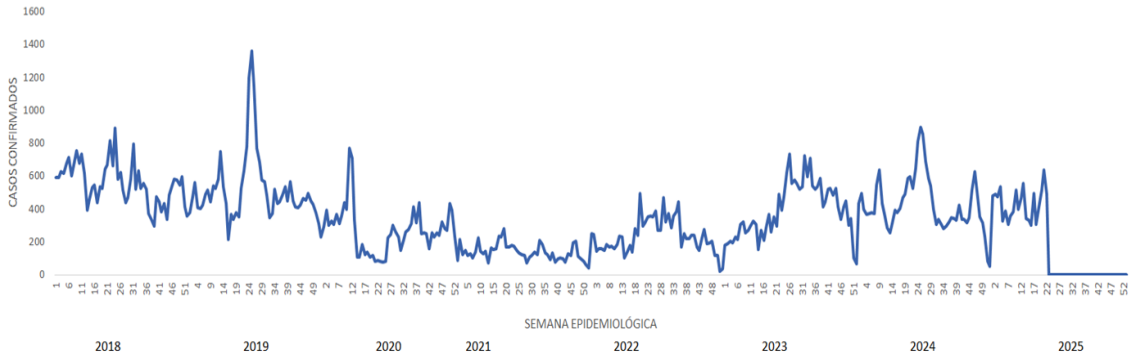
Gráfico 13.
Distribución de casos reportados por boleta VE-02 de ETI a la semana epidemiológica 25, en Costa Rica, 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

En relación con el histórico de casos de ETI, por semana epidemiológica en Costa Rica, entre los años 2018 y 2025, esto se puede apreciar en el gráfico 14.

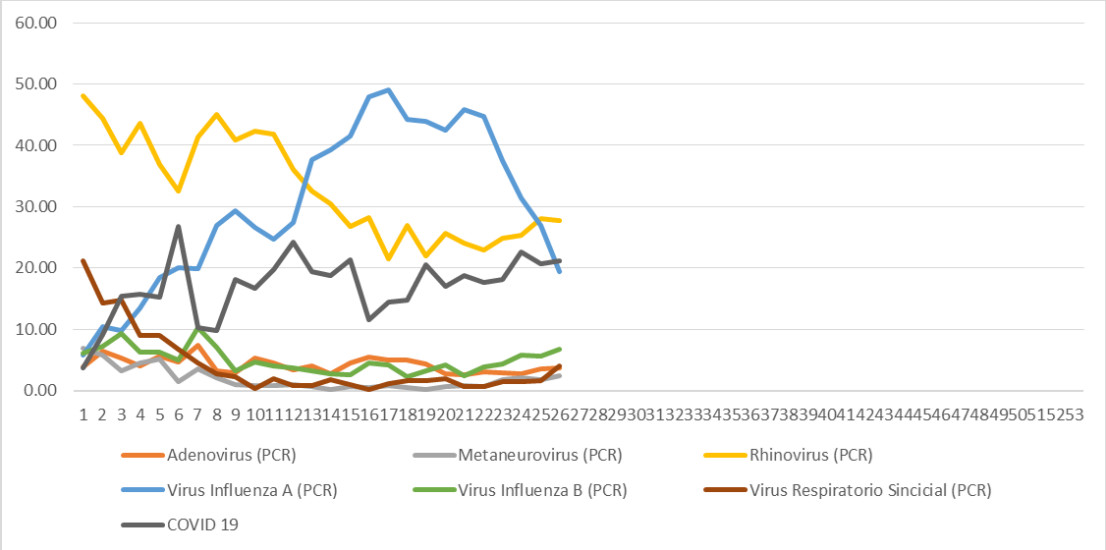
Gráfico 14.
Distribución histórica de casos de ETI por semana epidemiológica, en Costa Rica entre los años 2018 y 2025.



Fuente: Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de la Salud, UIS.

Según se observa en el gráfico 15, se puede ver el comportamiento de los principales virus respiratorios circulantes de la semana 01 a la 26; para la SE-26, en el país el Rinovirus es el que más está circulando, seguido del Covid-19 y finalmente el virus de la Influenza A está en tercer lugar de circulación.

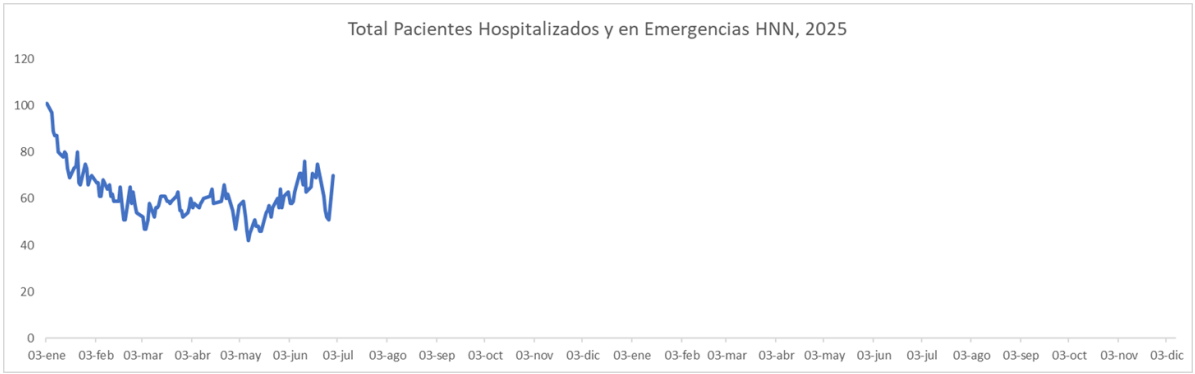
Gráfico 15.
Distribución de virus circulantes de la semana epidemiológica 01 a la 26 en Costa Rica, 2025.



Fuente: Matriz de Resultados de Laboratorio CCSS, Subárea de Vigilancia Epidemiológica 2025.

En relación con los datos específicos del Hospital Nacional de Niños, la situación que se ha presentado a la semana 27 del año 2025 es la siguiente:
Al 30 de junio del año en curso, correspondiente a la semana 27, el total de pacientes respiratorios hospitalizados son 66, lo que corresponde a un porcentaje de ocupación del 95.5%.

Gráfico 16.
Total de pacientes hospitalizados y en emergencias en la semana 25 del año 2025, Hospital Nacional de Niños.



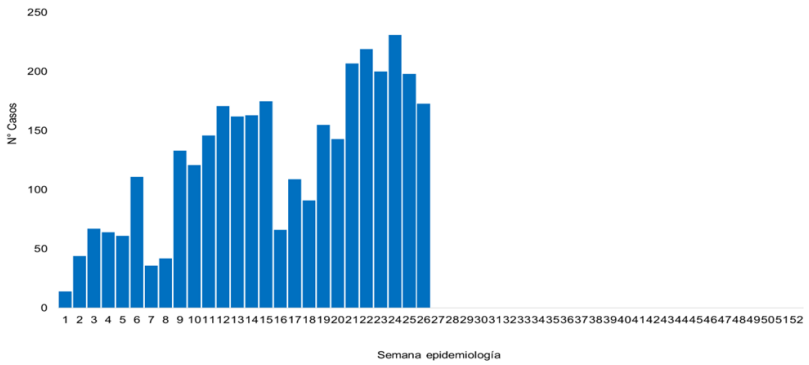
Fuente: Hospital Nacional de Niños, 2025.

Como observaciones finales se puede indicar lo siguiente:

- IRAG con 8140 casos a la semana 25.
- IRAS con 786641 casos a la semana 25.
- ETI con 11120 casos reportados a la semana 25.
- Actualmente, la ocupación de camas respiratorias en el HNN es de un 95.5%
- En SE-25, el Rinovirus es el virus que más ha circulado, seguido del Covid-19 y en tercer lugar circula el Virus de Influenza A.

Para la enfermedad por COVID-19, durante la semana epidemiológica 26, se reportaron un total de 173 casos confirmados, lo que representa una disminución del 12.66% con respecto a la SE-25 del año 2025 que presentó 198 casos.

Gráfico 17.
Costa Rica: Casos COVID-19, según semana epidemiológica año 2025.

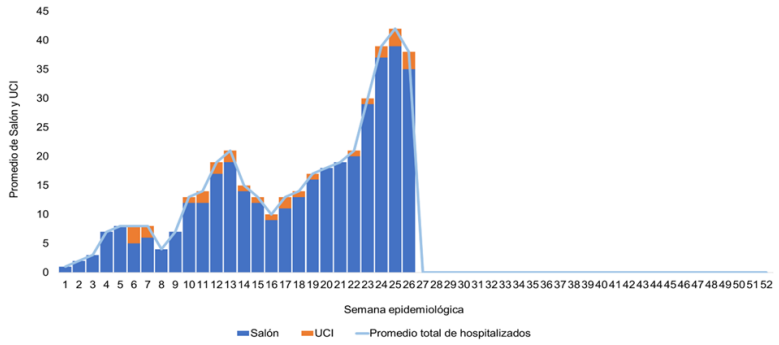


SE	Casos
1	14
2	44
3	67
4	64
5	61
6	111
7	36
8	42
9	133
10	121
11	146
12	171
13	162
14	163
15	175
16	66
17	109
18	91
19	155
20	143
21	207
22	219
23	200
24	231
25	198
26	173

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, C.C.S.S / Dirección de Vigilancia de Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Con respecto a las hospitalizaciones en la semana epidemiológica 26, se reportó un promedio total de 32 hospitalizados, lo que representa una disminución del 9.5% con respecto a la SE-25 del año 2025 donde se registraron 42 hospitalizaciones.

Gráfico 18.
Costa Rica: Promedio total de hospitalizados en salón y Unidad de Cuidados Intensivos, según reporte semanal año 2025.

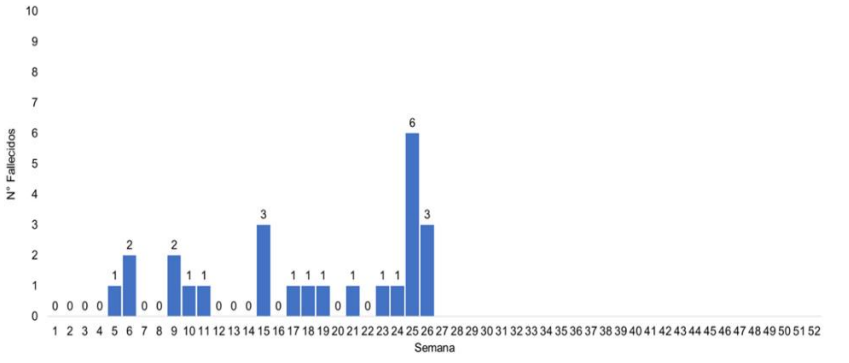


SE	Salón	UCI	Promedio total de hospitalizados
1	1	0	1
2	2	0	2
3	3	0	3
4	7	0	7
5	8	0	8
6	5	3	8
7	6	2	8
8	4	0	4
9	7	0	7
10	12	1	13
11	12	2	14
12	17	2	19
13	19	2	21
14	14	1	15
15	12	1	13
16	9	1	10
17	11	2	13
18	13	1	14
19	16	1	17
20	18	0	18
21	19	0	19
22	20	1	21
23	29	1	30
24	37	2	39
25	39	3	42
26	35	3	38

Fuente: Área de Estadística en Salud, CCSS/Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

En relación con el comportamiento de las personas fallecidas asociadas a COVID-19, durante la semana epidemiológica 26, hubo 3 fallecidos; sin embargo, es importante indicar que estos son datos preliminares sujetos a la revisión de los casos.

Gráfico 19.
Costa Rica: Personas fallecidas asociadas a COVID-19, según reporte semanal año 2025.

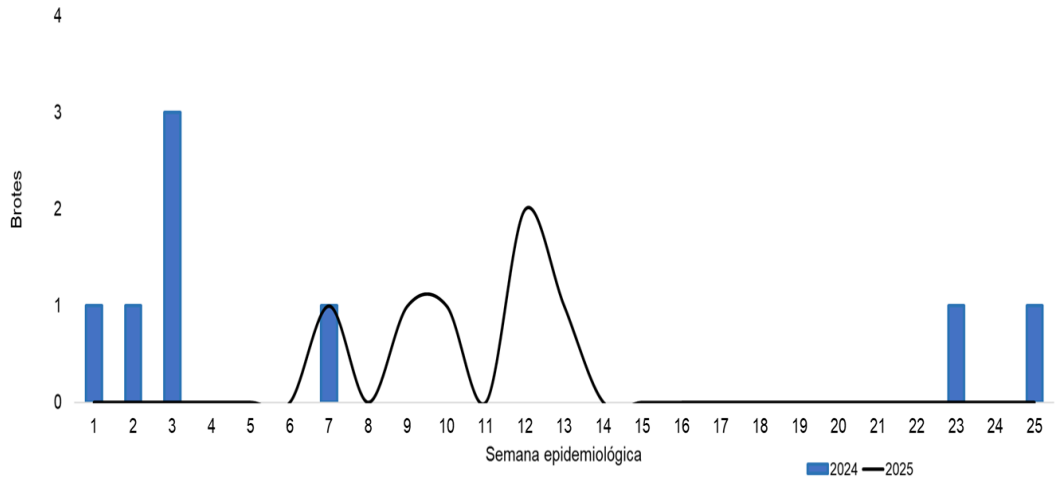


Semanas	Fallecidos
1	0
2	0
3	0
4	0
5	1
6	2
7	0
8	0
9	2
10	1
11	1
12	0
13	0
14	0
15	3
16	0
17	1
18	1
19	1
20	0
21	1
22	0
23	1
24	1
25	6
26	3

Fuente: Área de Estadística en Salud, C.C.S.S. / Ministerio de Salud, Dirección de Vigilancia de Salud 2025.

Para la semana epidemiológica 25 no se reportó ningún brote asociado a COVID-19.

Gráfico 20.
Brotes de covid-19, por semana epidemiológica en Costa Rica, 2025.

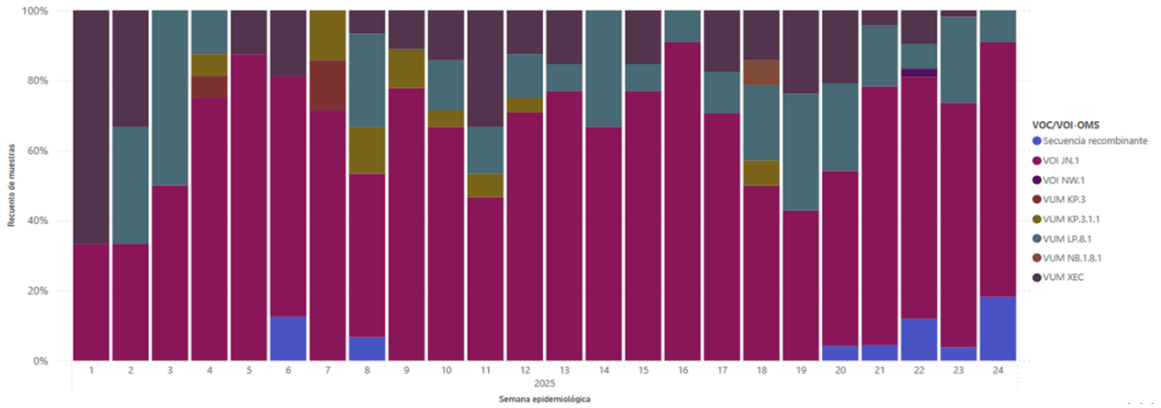


Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud, 2025.

Nota: Se reportaron 24 brotes en el año 2024 y se han reportado 6 brotes en el año 2025.

Variantes genómicas
Según el informe interactivo de INCIENSA revisado el 2 de julio del 2025, se reporta lo siguiente.

Gráfico 21.
Costa Rica: Proporción de linaje identificados, para Variante de Preocupación (VOC) Ómicron, Variante de Interés (VOI) y Variantes Bajo Monitoreo (VUM), por semana epidemiológica SE 1-24 del 2025.



Fuente: Sistema de Información de INCIENSA, CCSS, DATOS Facultad de Microbiología UCR, actualizado en informe interactivo en Vigilancia genómica SARS-CoV-2 al 2 de julio del 2025.

En relación con la proporción relativa de sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el periodo comprendido entre la SE-1 y la 24 del año 2025, se tiene la siguiente información.

Cuadro 1
Costa Rica: Proporción relativa de Sublinaje de VOC Ómicron, VOI y VUM, durante el período de las semanas epidemiológicas 1-24 del 2025

Linaje Pangolin	Cantidad	%
Secuencia recombinante	14	3.49
VOI JN.1	265	66.08
VOI NW.1	1	0.25
VUM KP.3	2	0.50
VUM KP.3.1.1	10	2.49
VUM LP.8.1	62	15.46
VUM NB.1.8.1	1	0.25
VUM XEC	46	11.47
Total	401	100.00

Fuente: INCIENSA, informes interactivos de variantes genómicas, corte 30 de junio 2025

Sarampión

José Aaron Agüero Zumbado
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

Situación Epidemiológica Mundial

La **Organización Panamericana de la Salud (OPS)** informa que entre la semana epidemiológica 1 y la 24 del año 2025, se han confirmado **7132 casos de sarampión** en la Región de las Américas, incluyendo **13 defunciones.**

Los casos se han presentado en Canadá (3170 casos, una defunción), México (2597 casos, nueve defunciones), Estados Unidos (1227 casos, tres defunciones), Bolivia (60), Argentina (34), Belice (34), Brasil (5), Perú (4) y Costa Rica (1). Los grupos de edad con más casos son los de **10 a 19 años** (24 %), y los de **20 a 29 años** (19 %).

Situación Epidemiológica en Costa Rica

En Costa Rica, el año 2025, se han notificado 39 casos sospechosos de sarampión descartándose por laboratorio y confirmándose un solo caso importado de sarampión por laboratorio el 15 de mayo en la provincia de Guanacaste.

En Costa Rica el último caso endémico de sarampión se detectó en 1999, y de Rubéola en el 2001. Los equipos de vigilancia interinstitucionales han detectado posteriormente, en el año 2019 un total de 10 casos de sarampión, 3 casos importados (en personas extranjeras,), y 7 asociados a la importación (caso confirmado por laboratorio, adquirida localmente y que forma parte de una cadena de transmisión originada por un caso importado). En el año 2023 se detectó 1 caso de fuente desconocida, confirmado por vigilancia en el laboratorio, posterior a investigaciones no se encontraron casos secundarios. En el año 2024, no se confirmaron casos.

Actividades complementarias de prevención y promoción en la vigilancia del sarampión.

El sector salud desde el año 2023 ha fortalecido la vigilancia, las coberturas de vacunación, el diagnóstico y la respuesta a brotes con el fin de proteger a los costarricenses y estar alertas ante casos o brotes de sarampión. En las diferentes actividades realizadas, ha participado el personal de los tres niveles de gestión (nacional, regional y local) de la CCSS, Ministerio de Salud e Inciensa.

1-Campaña de vacunación en niños en el 2024: resultando un 90,7% de cobertura y 95% en verificación final de campo. Los lineamientos mundiales y regionales de expertos recomiendan mejorar las coberturas para proteger a la población.

Imagen 1.
Equipos del Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa y OPS, 2024



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

2-Búsquedas Activas Comunitarias (BAC)

El país ha realizado otras actividades para fortalecer la detección y vigilancia del sarampión como lo es la **Búsqueda Activa Comunitaria (BAC)**, que consiste en establecer equipos de trabajo interinstitucionales Ministerio de Salud, CCSS e Inciensa, y realizar búsqueda de casos sospechosos de sarampión, según criterios de tiempo, lugar y persona, mediante entrevistas con actores sociales en visitas domiciliarias y otros. Para los BAC, el equipo designado acude a la comunidad para realizar una búsqueda intencional de casos de sarampión visitando las casas, se explica a la familia que es el sarampión, como se transmite, como se manifiesta en la persona (por medio de un brote o exantema y fiebre), el personal de salud pregunta si algún familiar ha presentado esta condición en los últimos 30 días con el fin de encontrar casos de sarampión. Los profesionales de salud al finalizar la entrevista generan recomendaciones y atienden aspectos de la enfermedad.

Resultados de los BAC

Desde el último trimestre del 2023, durante el 2024 y el primer semestre del 2025 se realizaron 219 búsquedas activas de casos en la comunidad, en localidades o barrios, abarcando más de 74 cantones del país, resultando 6 701 casas visitadas, 7067 personas entrevistadas, sin encontrar casos de sarampión.

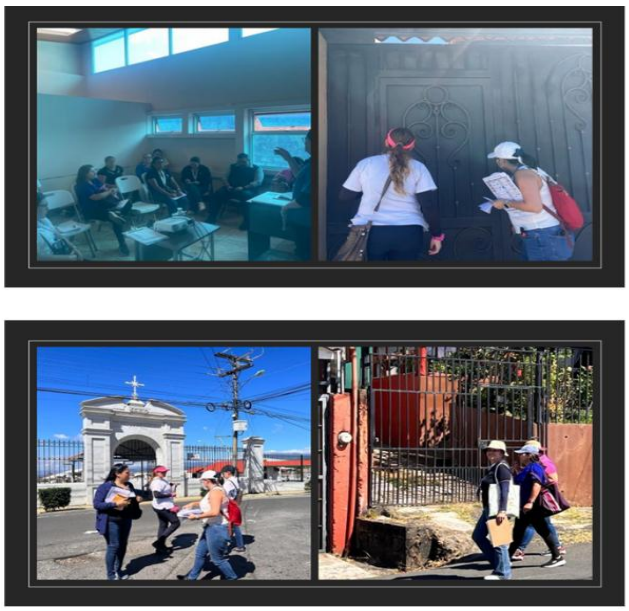
Imagen 2.
Búsquedas de Casos de Sarampión, Equipos del Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa y OPS, en 2024

Región Chorotega (Guanacaste) **Región Huetar Caribe (Limón)**



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

Región Central Norte (Heredia)



Región Central Este (Cartago)



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

Imagen 3. Búsquedas de Casos de Sarampión, Equipos del Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa y OPS, en 2024

Los Chiles
(Frontera con alto tránsito de extranjeros)



Región Central Sur
(San José)



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

3-Capacitaciones nacionales y regionales

En diciembre del 2024 y en marzo 2025, se realizaron las capacitaciones nacionales al sector público y privado, y la socialización del Protocolo Nacional para la Vigilancia y Atención de Brotes del Sarampión 2025(disponible en página web del Ministerio de Salud). En el 2024 y 2025 se han realizado capacitaciones nacionales y regionales respecto a la situación epidemiológica del sarampión mundial y de la región de las Américas, así como la vigilancia, aspectos de laboratorio y respuesta a brotes.

Imagen 4.
Capacitación a los equipos interinstitucionales del Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa y OPS, en 2024

Región Pacifico Central (Puntarenas)



Región Huetar Norte (Alajuela)



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

Región Occidente (Alajuela, Palmares)



Región Brunca (Pérez Zeledón)



Fuente: Equipo de Vigilancia Interinstitucional de Sarampión

Recomendaciones para la población

-Revisar esquemas de vacunación sarampión, y completarlos, principalmente en niños (contar como mínimo con 2 dosis de vacuna).

-Si inicia con un brote o erupción maculo papular que inicia en la cabeza, luego en cara, tronco y extremidades, asistir al establecimiento de salud correspondiente, debe informar si estuvo en contacto con extranjeros enfermos o si viajó a países con casos de sarampión.

- Si se enferma en Costa Rica y le diagnostican por laboratorio la enfermedad de sarampión, debe continuar aislamiento y los profesionales en salud realizarán un seguimiento respectivo.

Los países con más casos de sarampión son México, Canadá, USA, Bolivia y Argentina.

-Si realizan viajes a países donde existen brotes de sarampión, se recomienda tanto en niños como adultos contar como mínimo con dos dosis de vacuna. Además,

como recomendación, se pueden aplicar una vacuna de refuerzo como medida de protección.

-En países donde existe casos de sarampión, se recomienda usar mascarilla, medidas de higiene como el protocolo del lavado de manos, entre otros.

-Si viajó a países con brotes de sarampión-rubéola y presenta síntomas de estas enfermedades favor acudir al establecimiento de salud más cercano.

Recomendaciones al sector salud

- Mantener altas coberturas de vacunación iguales o mayores de 95%, con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas.
- Fortalecer los sistemas de vigilancia de enfermedad febril eruptiva, es decir, de personas con fiebre y erupción en piel o sarpullido, que permiten la identificación temprana de casos.
- Los equipos de vigilancia deben responder de forma rápida a casos confirmados por laboratorio a través de la vigilancia, mediante barridos de vacunación y búsqueda activa de otros casos. Seguir lo indicado en el Protocolo Nacional de Vigilancia 2025.

El Sarampión es una enfermedad causada por un virus, es muy contagiosa afecta principalmente a niños, y se transmite por pequeñas gotitas de la nariz, boca y faringe, al hablar, toser o estornudar. El enfermo inicia con malestar general, secreción nasal, tos, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas (manchas de Koplik), posteriormente, desarrolla fiebre alta, un brote de “manchas y pelotitas en piel” rojizo (exantema maculo-papular), generalmente inicia en la cara y cuello, luego pasa al tórax, abdomen y espalda, finalmente en brazos y piernas.

Los grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad son las poblaciones no vacunadas o con esquemas incompletos, por eso la importancia de mantener coberturas óptimas de vacunación. El sarampión es muy contagioso tiene capacidad de infectar a 18 personas por cada persona enferma.

El diagnóstico del sarampión se confirma por exámenes de laboratorio, en Costa Rica el Centro Nacional de Referencia Virológica del Inciensa es el laboratorio nacional que confirma los casos de sarampión.

El tratamiento para el sarampión es individualizado y conservador según el médico tratante, sin embargo, pueden presentar complicaciones. Todo caso se vigila diariamente, y si desarrolla complicaciones se debe trasladar a un hospital.

En Costa Rica, las **coberturas de vacunación** contra Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP) han mejorado las coberturas alcanzadas con la primera dosis (superiores al 95%) y con segundas dosis (con coberturas por debajo del 90%). Parte de la prevención es contar con el esquema completo de vacunación contra SRP, por lo que recomendamos a nuestra población completar el esquema de vacunación, y muy importante, también antes de viajar a los sitios donde actualmente se reportan brotes.

Protocolo para la vigilancia epidemiológica del Sarampión

Debido a la alerta sanitaria de casos de sarampión, el Ministerio de Salud hace de conocimiento, la actualización del Protocolo para la Vigilancia del Sarampión y Rubéola, elaborado por el Equipo Técnico Nacional (Ministerio de Salud, CCSS, Inciensa) y colaboradores expertos de Costa Rica y de OPS-OMS. El protocolo se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud, en el siguiente enlace: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/biblioteca-de-archivos-left/documentos-ministerio-de-salud/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-guias-y-lineamientos/protocolos-vigilancia-de-la-salud/8802-protocolo-para-la-vigilancia-epidemiologica-del-sarampion-rubeola-2025/file

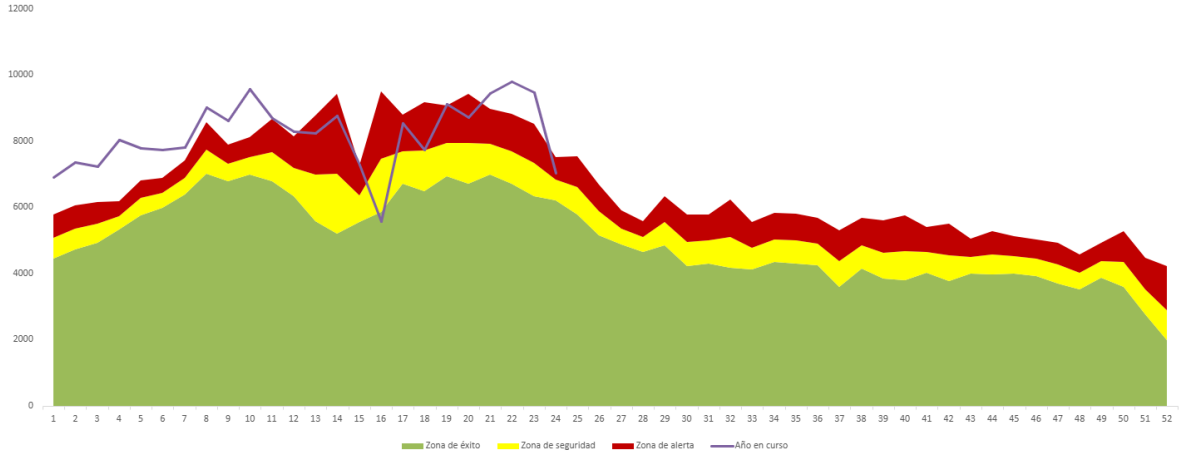
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 2 de julio 2025.

Ivannia Caravaca Rodríguez.
Unidad de Epidemiología.
Dirección de Vigilancia de la Salud

En la semana epidemiológica 25 del 2025 se presentan 208005 casos acumulados de EDA. Según el comportamiento epidemiológico de este evento, se denota una curva epidémica en zona de alerta, con una tasa de 3883,9 casos de diarrea por cada 100 000 habitantes.

La incidencia de las EDA para la Semana Epidemiológica (SE) 25 refleja una disminución de casos notificados en relación con el 2023, año referente por el registro del aumento de casos y tasas por 100 000 habitantes en todo el territorio nacional. Para la SE 25 se continúa observando una predisposición disminuida en la frecuencia de casos, observándose una tendencia a la baja comparado con los años anteriores, es evidente que los fenómenos climáticos del niño y la niña afectan la cantidad de casos de diarrea, este año con el fenómeno de la niña se muestra a la fecha el canal endémico en zona de alerta situación semejante en el año 2023 donde se atravesó el mismo fenómeno. Se destaca que los datos son preliminares, y actualmente se encuentran los datos en revisión, por lo que puede presentarse afectación en el canal endémico.

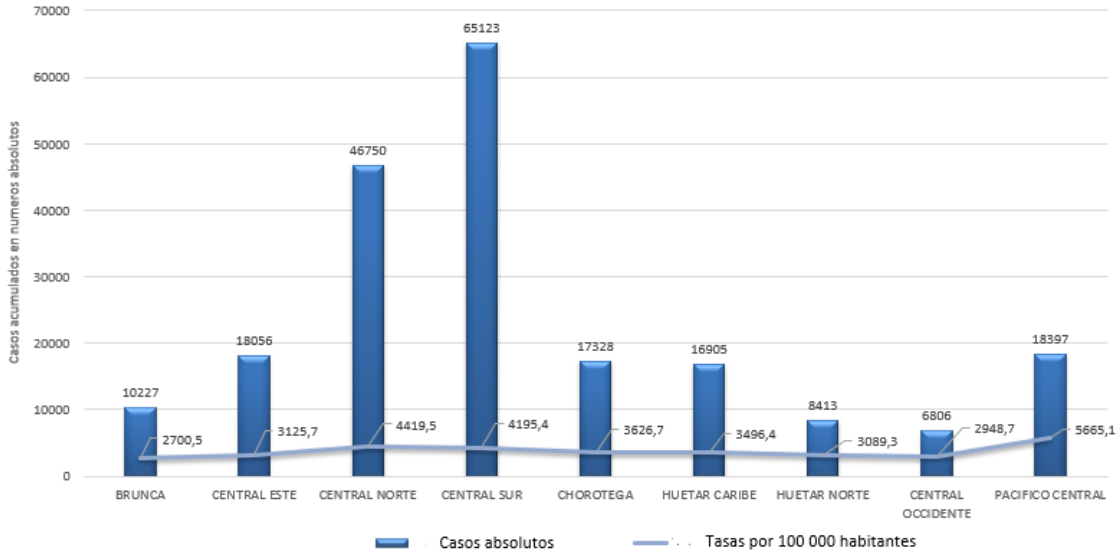
Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 25. Años 2017- 2025. (Se excluyen del 2020 al 2022 por pandemia COVID-19)



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Los 12 cantones con mayores tasas de incidencia de EDA a la SE 25 son: Santa Cruz, Orotina, Vázquez de Coronado, Puntarenas, Garabito, Montes de Oro, Flores, San Rafael, Alajuela, Matina, Goicochea, Parrita, donde predominan las tasas más altas. Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según región del Ministerio de Salud. SE 25, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Se recomienda retomar las campañas de educación a la población del Protocolo de Lavado de Manos, las adecuadas prácticas de higiene personal y de cocción y manipulación de alimentos.
El sistema de salud reporta una alta frecuencia de casos de diarreas, ya sean virales o bacterianas, superiores al comportamiento usual, el Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos dirige el proceso de la investigación adecuada de los casos, así como los flujogramas de trabajo ante diferentes posibles causas, es importante retomar las actividades de vigilancia e investigación ante las alertas.

Meningitis

Franchina Murillo Picado
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Paola Pérez Espinoza
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

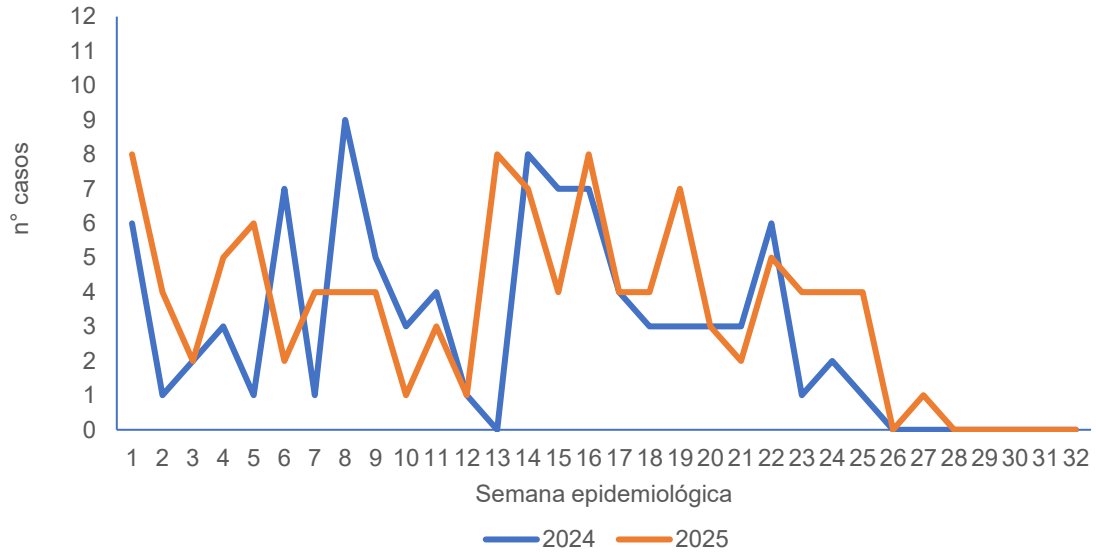
La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.

La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.

En Costa Rica, a la semana epidemiológica 25 del año 2025, se han reportado 109 casos por boleta VE01 por sospecha de meningitis con una tasa de incidencia de 2,0 por 100,000 habitantes. En el año 2024 se reportaron 91 casos de meningitis acumulado respecto a la misma semana con un aumento de 19,7%. No se registran brotes.

De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la región Central Este notificó el 27,5% de los casos (30/109), seguido de la Central Sur con el 23,9% (26/109) y Central Norte con el 19,3% (21/109).

Figura 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 25, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

En la siguiente tabla se enlista los cantones con las tasas más altas de meningitis. Dota de la provincia de San José es el que tiene la tasa más alta de 12,2 seguido están Cartago con 10,1 y Osa de la provincia de Puntarenas con 9,5.

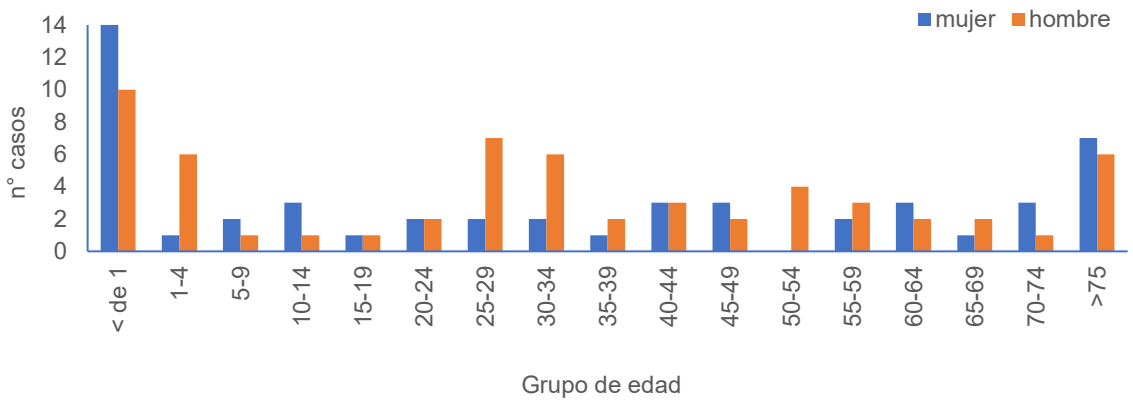
Figura 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según cantón, acumulado a la semana epidemiológica 25, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

cantón	casos	tasa
Dota	1	12,2
Cartago	17	10,1
Osa	3	9,5
Cañas	3	8,7
Leon Cortes	1	7,0
Santa Cruz	5	6,7
Alvarado	1	6,3
Jimenez	1	6,1
Sarapiqui	5	5,3
Tarrazu	1	5,2
Liberia	4	4,8
Santa Barbara	2	4,4
Valverde Vega	1	4,3
Talamanca	2	4,2
Flores	1	3,8
Perez Zeledon	5	3,5
La Union	4	3,4
Moravia	2	3,1
Aserri	2	3,0
Goicoechea	4	2,8
Quepos	1	2,8
Turrialba	2	2,7
Esparza	1	2,5
Palmares	1	2,3
Alajuela	7	2,1
El Guarco	1	2,1
San Jose	7	2,0
Desamparados	5	2,0
Alajuelita	2	2,0
Naranjo	1	2,0
Barva	1	2,0
Santo Domingo	1	2,0
Limon	2	2,0
San Rafael	1	1,7
Guacimo	1	1,7
Montes de Oca	1	1,6
Paraiso	1	1,5
Siquirres	1	1,5
Escazu	1	1,4
Heredia	2	1,3
Pococi	2	1,2
Grecia	1	1,0
San Carlos	1	0,5
Total	**109**	**2,0**

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3, indica la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. El 45,8% de los casos (50/109) son mujeres y el 54,1% (59/109) son hombres. El 22,0% de los casos (24/109) son menores de 1 año.

Figura 3.
Costa Rica: Casos sospechosos por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 25, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

Pamela Domínguez Saavedra
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

Stephany Alvarado Garita
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

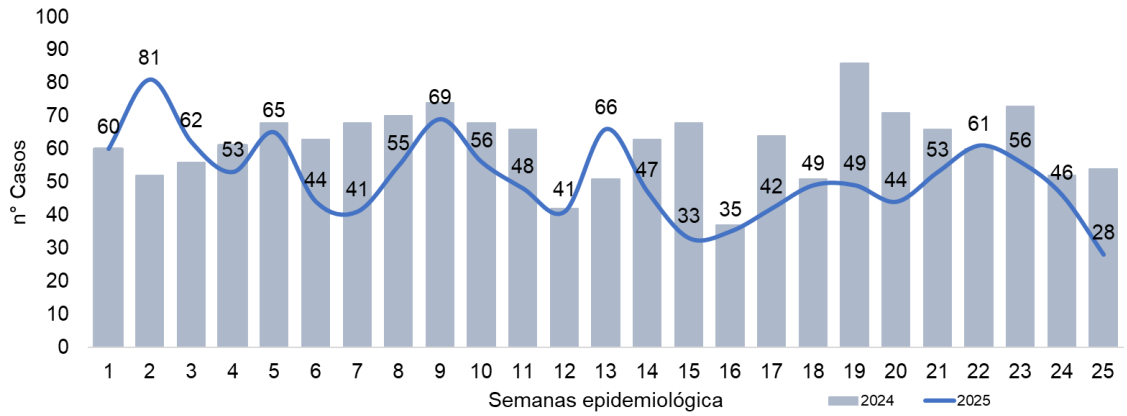
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), son de reporte obligatorio según el Reglamento de Vigilancia de la Salud 40556-S. Por consiguiente, la vigilancia es relevante para la salud pública del país. Para las primeras 25 semanas del año 2025, se han reportado las siguientes ITS: sífilis en todas sus formas, gonorrea, herpes virus y virus del papiloma humano.

Sífilis en todas sus formas

Es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*, la cual es totalmente prevenible y tratable. Esta infección se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el embarazo. Por ende, esta infección afecta a la morbilidad y mortalidad del país.

Para las primeras 25 semanas del 2025, se han notificado 1285 casos con una tasa 24,0 por 100 000 habitantes, en el mismo periodo del año 2024 se reportaron 1544 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 16,7% con 259 casos menos. En el gráfico 1, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad en las primeras 25 semanas del año, se reportaron en los hombres un 55,64% de los casos (715/1285), con una tasa de 26,5 por 100 000 habitantes, las mujeres presentan el 44,3% de los casos (570/1284), con una tasa de 21,4 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporto son: 20 a 64 años con 79,84% (1026/1285), seguidos por el de mayores de 65 años con 10.2% con (131/1285), luego por el grupo de 15 a 19 años con 4,8% con (62/1284), y los menores de 1 año con el 4,90% de los casos (63/1284), los menores de 10 a 14 años un caso, grupo de 1 a 4 años dos casos y el grupo de 5 a 9 años sin casos, ver cuadro 1.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	63	93,3
de 1 a 4 años	2	0,7
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	1	0,3
de 15 a 19 años	62	16,3
de 20 a 24 años	156	40,1
de 25 a 29 años	201	47,3
de 30 a 34 años	185	41,6
de 35 a 39 años	141	31,2
de 40 a 44 años	113	27,7
de 45 a 49 años	86	24,8
de 50 a 54 años	49	16,7
de 55 a 59 años	44	15,8
de 60 a 64 años	51	19,5
de 65 a 69 años	40	18,7
de 70 a 74 años	35	22,5
75 años y más	56	26,5
Total	1285	24,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el siguiente cuadro, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias.

Cuadro 2. Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos y tasas (Tasa p/100.000 habitantes), semana 25 del 2025

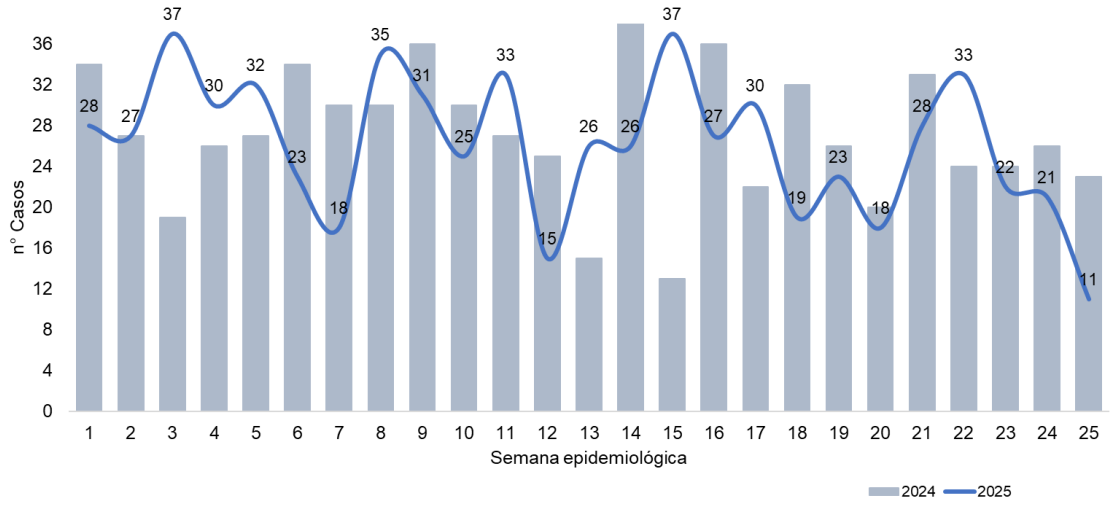
Provincias	Nº	Tasa
San José	478	27,8
Alajuela	158	14,5
Cartago	177	31,8
Heredia	65	11,6
Guanacaste	77	18,3
Puntarenas	102	19,3
Limón	228	47,2
Total	1285	24,00

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Gonorrea

Es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, la cual es prevenible y tratable. Esta enfermedad se trasmite por relaciones sexuales sin protección y de la madre al bebé durante el parto. Por consiguiente, esta infección afecta a la salud pública del país. En las primeras 25 semanas del 2025, se han notificado 655 casos con una tasa de 12,2 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 678 casos, lo que representa para el año 2025 un descenso del 3,4 % con 23 casos menos. En el gráfico 2, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento de esta enfermedad en las primeras 25 semanas del año en curso reporta en los hombres un 83,97% (550/655), con una tasa de 20,4 por 100 000 habitantes. En las mujeres se ha reportado el 16,30% (105/655), con una tasa de 3,9 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 82,14% (538/655), seguidos por el grupo de 15 a 19 año con 14,66% (96/655), y los mayores de 65 años con 2,29% (15/655), los menores de 1 año un caso y los de 1 a 14 años con cinco casos, ver cuadro 3.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	2	0,7
5 a 9	1	0,3
10 a 14	2	0,5
15 a 19	96	25,3
20 a 24	161	41,4
25 a 29	123	28,9
30 a 34	92	20,7
35 a 39	70	15,5
40 a 44	35	8,6
45 a 49	14	4,0
50 a 54	20	6,8
55 a 59	15	5,4
60 a 64	8	3,1
65 a 69	10	4,7
70 a 74	3	1,9
Más 75 años	2	0,9
Total	655	12,20

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 4, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 4
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

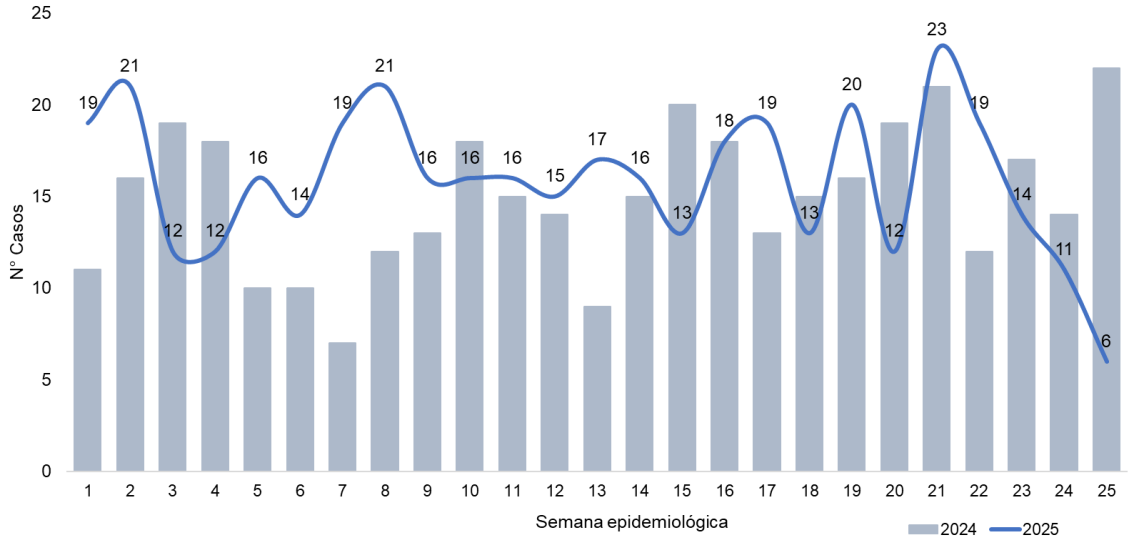
Provincias	Casos	Tasa
San José	257	15,0
Alajuela	84	7,7
Cartago	62	11,1
Heredia	38	6,8
Guanacaste	40	9,5
Puntarenas	72	13,7
Limón	102	21,1
Total	655	12,20

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus Herpes

El virus del herpes es otra de las Infección de transmisión sexual, que se ha reportado en las primeras 25 semanas del año en curso, con 398 casos con una tasa de 7,4 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 374 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 6,0%, con 24 casos más que el periodo anterior. En el gráfico 3, se presenta los datos según reporte semanal.

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del virus del herpes en las primeras 25 semanas del año se ha notificado en mujeres un 68,84% de los casos (274/398), con una tasa de 10,3 por 100 000 habitantes, en hombres se reportó el 31,16% de los casos con (124/398), con una tasa de 4,6 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad y los que reportan más son: 20 a 64 años con 81,91% (326/398), seguidos por 15 a 19 años con 13,07% (52/398), mayores de 65 años con 4,02% con (16/398), los menores de 1 año reportan un caso y el de 10 a 14 años con tres casos, los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 5.

Cuadro 5.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad, número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

Grupos de edad	Caso	Tasa
Menos 1 año	1	1,5
1 a 4	0	0,0
5 a 9	0	0,0
10 a 14	3	0,8
15 a 19	52	13,7
20 a 24	74	19,0
25 a 29	56	13,2
30 a 34	55	12,4
35 a 39	49	10,8
40 a 44	30	7,4
45 a 49	23	6,6
50 a 54	10	3,4
55 a 59	15	5,4
60 a 64	14	5,3
65 a 69	10	4,7
70 a 74	5	3,2
Más 75 años	1	0,5
Total	398	7,40

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 6
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

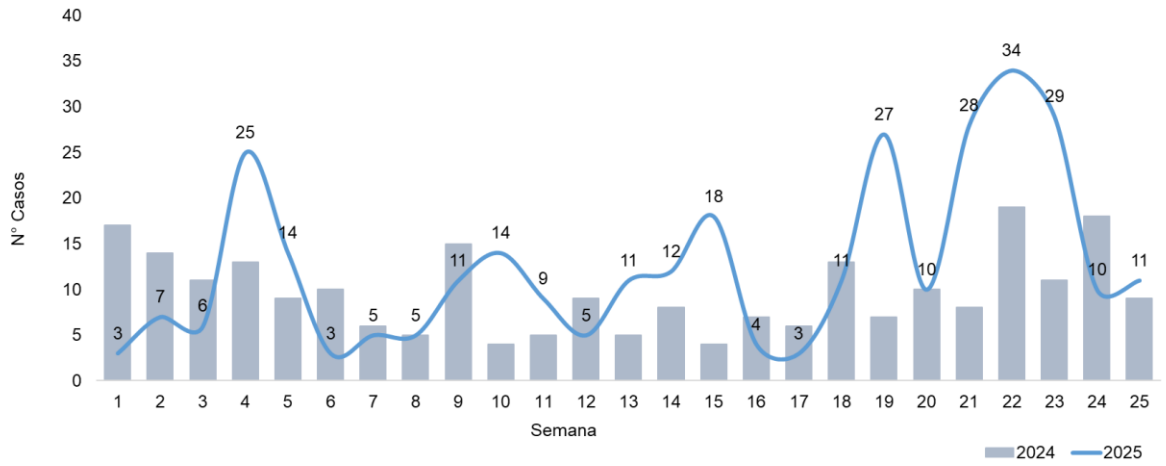
Provincias	Casos	Tasa
San José	201	11,7
Alajuela	36	3,3
Cartago	28	5,0
Heredia	17	3,0
Guanacaste	10	2,4
Puntarenas	51	9,7
Limón	55	11,4
Total	398	7,40

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Es una de Infección que se trasmite por por contacto de la piel o por relaciones sexuales sin protección, se puede prevenir con el uso de condones y no tener relaciones sexuales cuando la pareja tiene síntomas. En las primeras 25 semanas del 2025, se notificaron 315 casos con una tasas de 5,9 por 100 000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 243 casos, lo que representa para el año 2025 un incremento del 29,6%, con 72 casos más que el periodo anterior ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento del VPH en las primeras 25 semanas del año, según sexo se notificaron en las mujeres un 93,02% (293/315), con una tasa de 11,0 por 100 000 habitantes, en los hombres se reportó el 6,98% (22/315), con una tasa de 0,80 por 100 000 habitantes.

Los casos notificados por grupos de edad con mayor reporte son: 20 a 64 años con 97,80% (308/315), seguidos por 15 a 19 años con 1,9% (6/315), los mayores 65 años un caso y los otros grupos no reportan casos, ver cuadro 7.

Cuadro 7.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humanos, por grupos de edad. Número absoluto y tasa.
Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

Grupos de edad	Casos	Tasa
de Menos de 1 año	0	0,0
de 1 a 4 años	0	0,0
de 5 a 9 años	0	0,0
de 10 a 14 años	0	0,0
de 15 a 19 años	6	1,6
de 20 a 24 años	17	4,4
de 25 a 29 años	17	4,0
de 30 a 34 años	55	12,4
de 35 a 39 años	68	15,0
de 40 a 44 años	44	10,8
de 45 a 49 años	33	9,5
de 50 a 54 años	20	6,8
de 55 a 59 años	33	11,8
de 60 a 64 años	21	8,0
de 65 a 69 años	1	0,5
de 70 a 74 años	0	0,0
75 años y más	0	0,0
Total	315	5,90

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 8, se presentan el comportamiento de esta enfermedad, según las siete provincias del país.

Cuadro 8.
Costa Rica: Casos notificados por Virus del Papiloma Humano, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 25 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	49	2,9
Alajuela	25	2,3
Cartago	8	1,4
Heredia	7	1,3
Guanacaste	97	23,1
Puntarenas	125	23,7
Limón	4	0,8
Total	315	5,90

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Miasis por gusano barrenador en humanos

María José Lafuente González
Unidad de Epidemiología
Dirección de Vigilancia de la Salud

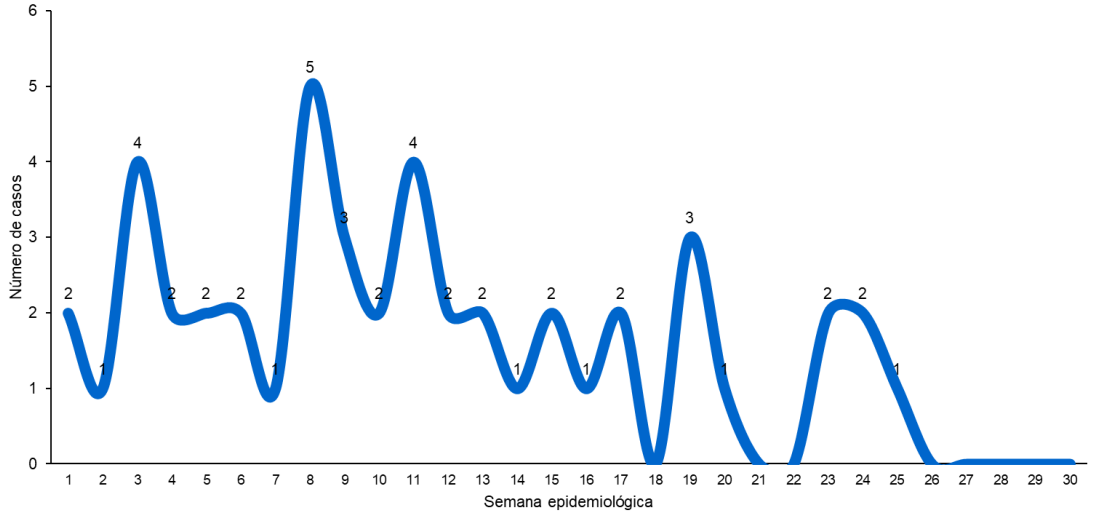
Rafael Alberto Chaves Méndez
Unidad de Indicadores en Salud
Dirección de Vigilancia de la Salud

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 26 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 26, se tienen los siguientes datos:

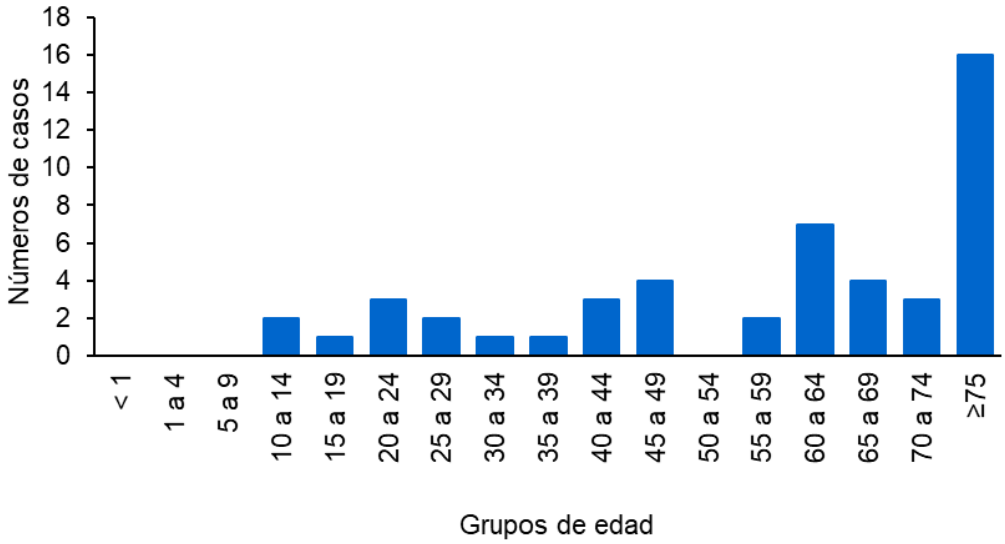
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 49 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (23/49) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (23/49)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 26, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 26, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 32 casos notificados con una tasa de 1,2 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 17 casos notificados con una tasa de 0,6 por 100.000 habitantes.

Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 26, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**49**	**0,9**
San José	8	0,5
Alajuela	11	1,0
Cartago	3	0,5
Heredia	5	0,9
Guanacaste	8	1,9
Puntarenas	8	1,5
Limón	6	1,2

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por provincia de procedencia, por casos y tasas por 100.000 habitantes notificados a la SE 26, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (11/49) seguido por la provincia de San José (8/49), Guanacaste (8/49) y Puntarenas (8/49).

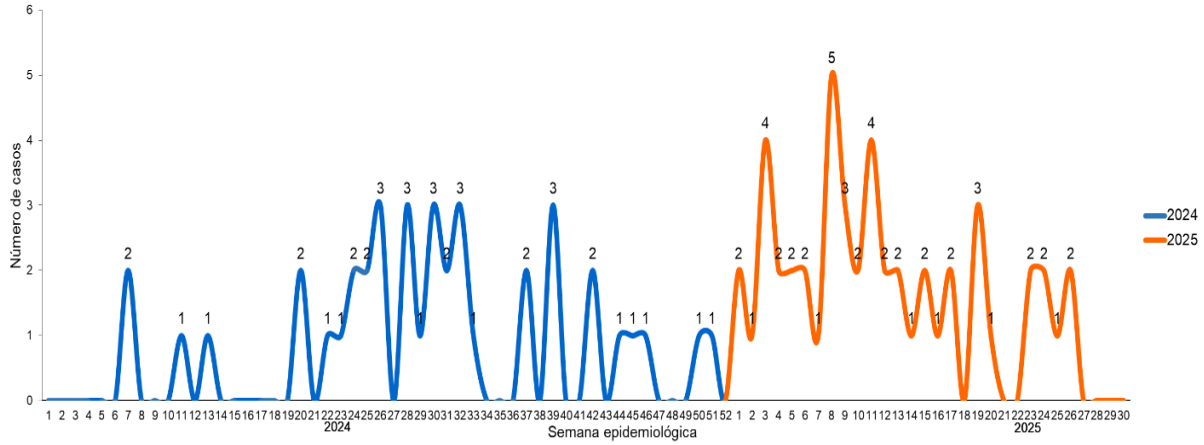
Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 26, 2025

Regiones	Casos	Tasas
Total	**49**	**0,9**
Central Norte	9	0,9
Chorotega	8	1,7
Central Sur	7	0,5
Brunca	6	1,6
Huetar Caribe	6	1,2
Central Occidente	5	2,2
Pacifico Central	4	1,2
Central Este	3	0,5
Huetar Norte	1	0,4

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 2, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Central Norte (9/49) la que presenta el mayor número de casos.

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, año 2024 al corte de la SE 26 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

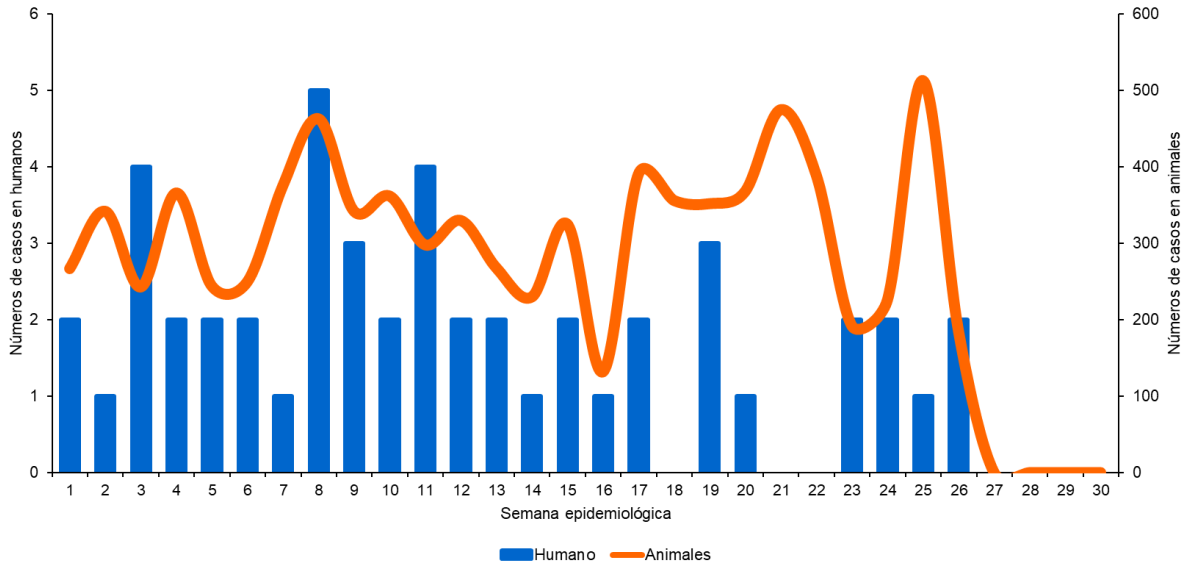
Cuadro 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador a la SE 26 del 2024 y 2025

SE	Número de casos	
	2024	2025
1	0	2
2	0	1
3	0	4
4	0	2
5	0	2
6	0	2
7	2	1
8	0	5
9	0	3
10	0	2
11	1	4
12	0	2
13	1	2
14	0	1
15	0	2
16	0	1
17	0	2
18	0	0
19	0	3
20	2	1
21	0	0
22	1	0
23	1	2
24	2	2
25	2	1
26	3	2
Total	**15**	**49**

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

En el gráfico 3 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 26 del 2025 y en el cuadro 3 el comportamiento de los casos de la SE 01 a 26 del 2024 y SE 01 a 26 del 2025, observando un aumento significativo de los casos durante la SE 08 del 2025, con un total de 49 casos confirmados por esta enfermedad, siendo que para la SE 26 del 2024 se confirmaron 15 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador en humanos y animales según SE de la 01 a la 26, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Boletín Epidemiológico Extraordinario Gusano Barrenador actualizado al 28 de junio del 2025, SENASA / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 4, se muestran los casos de miasis por gusano barrenador en humanos y animales por SE de la 01 a la 26 del 2025, con 49 casos confirmados en humanos y 8285 casos confirmados aproximadamente en animales.

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que ante la identificación de un caso sospechoso en humanos se realice el abordaje bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, mediante coordinación interinstitucional Ministerio de Salud-Servicio Nacional de Salud Animal-Ministerio de Ambiente y Energía según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales que puedan ser atendidos de manera oportuna.

A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión herida
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna